

Clínica Médica

Material de revisão rápida · Clínica Médica

PARTE I — INFECTOLOGIA

1.1 HIV/aids

Cenário típico de prova: paciente com IST prévia, parceiros múltiplos, uso de drogas injetáveis, ou gestante — mas também, cada vez mais, **paciente sem fator de risco aparente**, pois o rastreio deve ser universal.

Diagnóstico: fluxograma com dois testes — **teste rápido 1** seguido de **teste rápido 2** de fabricante/princípio diferente (mesmo dia, dois locais); ou **imunoensaio de 4ª geração** seguido de **teste molecular (carga viral)** confirmatório. **Toda pessoa sexualmente ativa deve ser testada ao menos uma vez na vida**; gestantes em cada trimestre e no momento do parto.

Estadiamento (CDC): classifica-se pela contagem de CD4 e/ou por condições definidoras de aids (independe da contagem se houver uma condição definidora).

Tratamento: TARV para todos, independentemente de CD4 ou carga viral, com início o mais precoce possível — inclusive no mesmo dia do diagnóstico ("teste e trate"), quando possível.

Esquema preferencial de 1ª linha: tenofovir + lamivudina + dolutegravir (TDF/3TC/DTG), coformulação em dose única diária.

Efeitos adversos a saber: **tenofovir** (nefrotoxicidade, redução de densidade óssea), **dolutegravir** (ganho de peso, insônia; ajustar dose se com rifampicina), efavirenz (saiu do esquema preferencial — sintomas neuropsiquiátricos).

Metas: **carga viral indetectável em até 6 meses**. **Indetectável = intransmissível (I=I)** — pode ser cobrado em questão sobre orientação ao paciente ou sobre risco de transmissão vertical/sexual.

Coinfecção TB-HIV: tratar a tuberculose primeiro; iniciar TARV em **até 2 semanas se CD4 < 50**, em **até 8 semanas** nos demais casos; ajustar dolutegravir (dose 12/12h) com rifampicina.

Falha virológica: carga viral detectável após 6 meses de TARV com boa adesão → genotipagem e troca de esquema.

Profilaxias primárias por CD4 — pergunta clássica "qual a profilaxia indicada":

CD4	PROFILAXIA	CONTRA
< 200	Sulfametoxazol-trimetoprima	Pneumocistose (e cobre toxoplasmose)
< 100	manter SMX-TMP	Toxoplasmose
< 50	Considerar azitromicina	Complexo <i>Mycobacterium avium</i> (MAC)

Infecções oportunistas — o quadro que a prova descreve, não o nome:

1.1 HIV/aids — continuação

Pneumocistose (*Pneumocystis jirovecii*): CD4 < 200, **dispneia progressiva e tosse seca de instalação subaguda, hipoxemia desproporcional ao exame físico e ao RX**, RX/TC com infiltrado intersticial difuso em "vidro fosco", **LDH elevada**. Tratamento: **SMX-TMP em altas doses; corticoide se PaO₂ < 70 mmHg ou gradiente alveoloarterial elevado** (reduz mortalidade e a piora paradoxal ao iniciar o antimicrobiano).

Neurotoxoplasmose: CD4 < 100, cefaleia, febre, **déficit neurológico focal**, convulsão; TC/RM com **lesões com realce em anel**, geralmente múltiplas. Tratamento empírico com **sulfadiazina + pirimetamina + ácido folínico**; reavaliar em 2 semanas — a falha de resposta sugere linfoma primário de SNC (indicação de biópsia).

Meningite criptocócica: CD4 < 100, cefaleia subaguda, febre baixa, **pouca rigidez de nuca; tinta da China ou antígeno criptocócico** no líquido. Tratamento com anfotericina B + flucitosina, seguido de fluconazol. **Punções de alívio são essenciais** para controlar a hipertensão intracraniana.

Citomegalovírus: CD4 < 50; **retinite** (perda visual, "queijo com ketchup" na fundoscopia — risco de cegueira, tratar sempre), colite, esofagite → ganciclovir/valganciclovir.

Complexo *Mycobacterium avium* (MAC): CD4 < 50, febre, sudorese, perda de peso, diarreia, hepatoesplenomegalia, anemia — doença disseminada.

Leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP): vírus JC, CD4 baixo, déficits neurológicos multifocais progressivos sem efeito de massa; sem tratamento específico além da TARV.

Sarcoma de Kaposi: lesões cutâneas violáceas, associado ao HHV-8; pode acometer mucosas e vísceras.

Tuberculose: a infecção oportunista **mais comum** em pessoas vivendo com HIV no Brasil e a **principal causa de óbito** nessa população — pode ocorrer em qualquer nível de CD4, com apresentação atípica (extrapulmonar, miliar) nos mais imunodeprimidos.

Candidíase esofágica: odinofagia com ou sem placas orais visíveis → tratamento empírico com fluconazol, sem necessidade de endoscopia de imediato.

PrEP e PEP:

PEP (profilaxia pós-exposição): iniciar **o mais rápido possível, idealmente nas primeiras 2 horas, com limite de 72 horas**; esquema por **28 dias**, TDF/3TC/DTG. Indicada em exposição sexual desprotegida, violência sexual e acidente ocupacional com material biológico.

PrEP (profilaxia pré-exposição): para populações-chave e de maior vulnerabilidade; disponível em esquema oral diário, **PrEP sob demanda (esquema 2-1-1)** para relações programadas, e formulações injetáveis de longa duração conforme disponibilidade e protocolo vigente.

PARTE I — INFECTOLOGIA

1.2 Infecções sexualmente transmissíveis

A prova costuma pedir a conduta **sindrômica**, não necessariamente o agente confirmado:

SÍNDROME	CONDUTA
Corrimento uretral/cervical (gonococo + clamídia, tratamento empírico duplo)	Ceftriaxona 500 mg IM + azitromicina 1 g VO , dose única, tratando o casal
Úlcera genital	Ver diferencial abaixo — tratamento conforme a hipótese mais provável, podendo ser combinado se dúvida
Corrimento vaginal	Ver Rapid Review de GO
DIP	Ver Rapid Review de GO
Verrugas anogenitais (condiloma)	Ácido tricloroacético, imiquimode, eletrocauterização ou exérese, conforme extensão

Diferencial das úlceras genitais:

AGENTE	ÚLCERA	ADENOPATIA
Sífilis primária	Única, indolor, fundo limpo, bordas endurecidas (cancro duro)	Bilateral, indolor, móvel
Herpes genital	Múltiplas vesículas/erosões dolorosas , recorrentes, precedidas de ardência	Dolorosa na primoinfecção
Cancro mole (<i>H. ducreyi</i>)	Múltiplas, dolorosas, fundo sujo , bordas irregulares e solapadas	Bubão unilateral que fistuliza por orifício único
Linfogranuloma venéreo (<i>C. trachomatis</i> L1-L3)	Pápula/erosão fugaz, muitas vezes despercebida	Bubão que fistuliza em "bico de regador" (múltiplos orifícios)
Donovanose (<i>Klebsiella granulomatis</i>)	Úlcera crônica, indolor, vegetante , sangra facilmente ao toque	Ausente (o próprio granuloma pode mimetizar linfonodo — "pseudobubão")

Sífilis — a mais cobrada das ISTs:

Tratamento é sempre com penicilina benzatina, mesmo em gestante (dessensibilizar se alérgica — é o único tratamento que também trata o feto).

Recente (primária, secundária, latente < 1 ano): **2,4 milhões UI, dose única**.

Tardia/indeterminada/terciária: **2,4 milhões UI por semana, 3 semanas** (total 7,2 milhões).

Neurosífilis: penicilina cristalina EV 10–14 dias — suspeitar com sintomas neurológicos, oculares ou auditivos.

Controle de cura: VDRL trimestral no primeiro ano; espera-se **queda de pelo menos 2 diluições em 3–6 meses**. Ausência de queda ou elevação = retratamento e investigar neurosífilis/reinfecção.

Reação de Jarisch-Herxheimer: febre, mialgia e piora transitória das lesões nas primeiras 24 h após a primeira dose — **não é alergia**, não contraindica a continuidade do tratamento; orientar antitérmico.

Notificação compulsória de todas as formas.

PARTE I — INFECTOLOGIA

1.3 Tuberculose

Cenário típico: paciente com fator de risco (contato domiciliar, população em situação de rua, privação de liberdade, HIV, imunossupressão) e **tosse por 3 semanas ou mais** (2 semanas em populações vulneráveis), associada a febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento.

Diagnóstico: teste rápido molecular (TRM-TB) no escarro é o exame inicial de escolha — detecta simultaneamente o *M. tuberculosis* e a resistência à rifampicina. **Cultura com teste de sensibilidade** obrigatória em: retratamento, falência terapêutica, contato de caso resistente, população vulnerável e pessoas vivendo com HIV. Baciloscopia (BAAR) segue sendo usada para monitorar a resposta ao tratamento.

Radiografia: cavitação em lobos superiores é o padrão clássico da forma pós-primária do adulto; padrão miliar em imunodeprimidos.

Esquema básico (RHZE — adulto e adolescente):

2 meses de RHZE (fase intensiva) + 4 meses de RH (fase de manutenção).

Formas meningoencefálica e osteoarticular: fase de manutenção estendida para **10 meses** (tratamento total de 12 meses); na meningoencefálica, associar **corticoide** (prednisona ou dexametasona) por 4–8 semanas.

Tuberculose extrapulmonar — reconhecer pelo quadro:

Pleural: derrame exsudativo linfocítico com **ADA elevada**, geralmente unilateral.

Ganglionar (escrofulose): linfonodomegalia cervical de evolução arrastada, podendo fistulizar.

Meningea: subaguda, cefaleia, rebaixamento, paralisia de nervos cranianos, líquido com predomínio linfomonocitário, proteína alta e glicose baixa.

Osteoarticular (mal de Pott): dor lombar/torácica progressiva com **destruição de corpos vertebrais**, podendo evoluir com déficit neurológico.

Renal, pericárdica, peritoneal: diagnósticos de exclusão em contextos compatíveis, muitas vezes exigindo biópsia.

Miliar: disseminação hematogênica, mais comum em imunossuprimidos e extremos de idade; padrão radiológico difuso em "grão de milho".

Efeitos adversos que a prova cobra (associar fármaco ao efeito):

Isoniazida → neuropatia periférica (prevenir/tratar com **piridoxina**) e hepatotoxicidade.

Rifampicina → **coloração alaranjada de urina, suor e lágrimas** (efeito esperado, **não suspender**), hepatotoxicidade, interação com anticoncepcionais e antirretrovirais.

Pirazinamida → hepatotoxicidade e **hiperuricemia** (pode desencadear gota).

Etambutol → **neurite óptica** (discromatopsia para vermelho-verde — avaliar acuidade visual antes de iniciar).

Suspender o esquema se transaminases > 3× o limite com sintomas, ou > 5× sem sintomas; reintroduzir escalonadamente após normalização.

Infecção latente (ILT): contato assintomático, radiografia normal, com **PT ≥ 5 mm** (ou IGRA positivo). Esquemas: **isoniazida por 6–9 meses, rifampicina por 4 meses**, ou **isoniazida + rifapentina semanal (3HP) por 12 semanas** — este último com melhor adesão por ser mais curto.

Populações especiais: gestante trata normalmente com RHZE (piridoxina associada); criança contactante assintomática entra em ILTB; RN de mãe bacilífera não recebe BCG de imediato (ver Rapid Review de Pediatria). Notificação compulsória e tratamento diretamente observado (TDO) são obrigatórios.

PARTE I — INFECTOLOGIA

1.4 Hanseníase

Cenário típico: lesão de pele com **alteração de sensibilidade** — a pista mais cobrada. Testar sensibilidade **térmica primeiro** (a mais precocemente perdida), depois dolorosa e tátil.

	PAUCIBACILAR	MULTIBACILAR
Número de lesões	Até 5	Mais de 5
Baciloscopia	Negativa	Pode ser positiva
Formas clínicas	Indeterminada, tuberculoide	Dimorfa, virchowiana
Tratamento (PQT-U)	6 doses mensais supervisionadas	12 doses mensais supervisionadas

Diagnóstico é clínico, baseado nos **três sinais cardinais** (basta um): lesão com alteração de sensibilidade, espessamento de nervo periférico com alteração de função, baciloscopia positiva.

Esquema PQT-U: rifampicina + dapsona + clofazimina para todas as formas (o que muda é o número de doses).

Reações hansênicas — não são falha terapêutica, não suspender a PQT:

- **Tipo 1 (reação reversa):** reagudização de lesões antigas, neurite (dor e espessamento de nervo com risco de dano permanente) → **corticoide (prednisona)**, com atenção especial se houver neurite (é urgência para preservar função neural).
- **Tipo 2 (eritema nodoso hansênico):** nódulos dolorosos, febre, mal-estar sistêmico, em pacientes virchowianos → **talidomida** — **contraindicada em mulheres em idade fértil sem contracepção rigorosa** (teratogenicidade grave); alternativa com corticoide se contraindicação à talidomida.

Avaliação de contatos domiciliares e vacinação BCG conforme a presença de cicatriz vacinal. Notificação compulsória.

PARTE I — INFECTOLOGIA

1.5 Hepatites virais

	A	B	C	D	E
Transmissão	Fecal-oral	Parenteral, sexual, vertical	Parenteral (principal)	Precisa do HBV (coinfecção/superinfecção)	Fecal-oral
Cronificação	Não	Adulto ~5%; RN infectado até 90%	~80%	Alta na superinfecção	Rara (exceto imunossuprimidos)
Vacina no calendário	Sim	Sim	Não	Indireta (vacina de hepatite B)	Não

Sorologia da hepatite B — o quadro que mais cai:

MARCADOR	INTERPRETAÇÃO
HBsAg +	Infecção presente (aguda se < 6 meses, crônica se persistir)
Anti-HBc IgM +	Infecção aguda ou reagudização
Anti-HBc IgG + (isolado ou com outros)	Contato prévio com o vírus
Anti-HBs + isolado	Vacinado , sem infecção prévia
Anti-HBs + com anti-HBc IgG +	Infecção curada
HBeAg +	Alta replicação viral e infectividade
Anti-HBe +	Menor replicação (exceto na variante pré-core)

Tratamento:

Hepatite B crônica: tenofovir ou entecavir, indicados conforme fase de replicação, fibrose e idade; objetivo é suprimir a replicação viral (cura funcional é rara).

Hepatite C: antivirais de ação direta (DAA) por 8–12 semanas, com taxa de cura **> 95%**; disponíveis no SUS.

Hepatite A e E: tratamento de suporte — são autolimitadas na maioria dos casos; **hepatite E em gestante pode ser grave**.

Hepatite fulminante: insuficiência hepática aguda com encefalopatia em até 8 semanas do início dos sintomas, sem doença hepática prévia — emergência, avaliar transplante.

PARTE I — INFECTOLOGIA

1.6 Arboviroses e endemias

Dengue — classificação de risco (Ministério da Saúde), pergunta certa de conduta prática:

GRUPO	PERFIL	CONDUTA
A	Sem sinais de alarme, sem comorbidade	Hidratação oral 60 mL/kg/dia (1/3 com SRO), retorno diário até 48h afebril
B	Sangramento espontâneo/prova do laço positiva, ou condição de risco (gestante, < 2 ou > 65 anos, comorbidade)	Hemograma, observação até resultado
C	Sinais de alarme	10 mL/kg/h EV nas primeiras 2 h, reavaliar, internação
D	Choque / dengue grave	20 mL/kg em até 20 minutos , UTI

Sinais de alarme: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural), hipotensão postural/lipotimia, **hepatomegalia > 2 cm**, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade, **aumento do hematócrito concomitante com queda rápida de plaquetas**. **Nunca usar AAS ou AINE** (risco hemorrágico). Notificação de casos e óbitos.

ARBOVIROSE	MARCA CLÍNICA
Chikungunya	Artralgia intensa e incapacitante , poliarticular, simétrica — pode cronificar por meses a anos
Zika	Exantema pruriginoso precoce com febre baixa/ausente, conjuntivite não purulenta; síndrome congênita (microcefalia) e associação com Guillain-Barré
Febre amarela	Febre alta, icterícia, sinal de Faget (dissociação pulso-temperatura), insuficiência hepatorenal, hemorragia; notificação imediata ; forma grave letal
Oropouche	Quadro semelhante à dengue, com recidivas frequentes ; entrou recentemente na lista de notificação compulsória
Febre do Nilo Ocidental	Febre, exantema, podendo evoluir com meningoencefalite — vigilância em expansão no Brasil

Outras endemias — reconhecer pelo contexto epidemiológico:

1.6 Arboviroses e endemias — continuação

Leptospirose: contato com água de enchente ou ambiente com roedores; **mialgia intensa em panturrilhas, sufusão conjuntival**, febre; forma grave = **síndrome de Weil** (icterícia rubínica + insuficiência renal + hemorragia pulmonar) → penicilina cristalina ou ceftriaxona, o quanto antes.

Malária: procedência de área endêmica (Amazônia Legal) + febre com periodicidade → **gota espessa imediata**, mesmo sem febre no momento da consulta. ***P. falciparum*** é a espécie grave (**malária cerebral, insuficiência renal, edema pulmonar**). Tratamento conforme espécie e gravidade; **primaquina** para eliminar hipnozoítos de *P. vivax* e *P. ovale* (cheçar deficiência de G6PD antes, risco de hemólise). Notificação.

Doença de Chagas aguda: no Brasil hoje, a principal via é a **transmissão oral** (açai e outros alimentos contaminados por triatomíneos); febre prolongada, miocardite, **sinal de Romaña** (edema bupalpebral unilateral, na forma vetorial clássica) → benznidazol; notificação imediata. **Forma crônica:** cardiopatia dilatada (arritmias, bloqueios, insuficiência cardíaca, risco de morte súbita) e megasôfago/megacôlon.

Esquistossomose: contato com água doce em área endêmica (Nordeste, MG); forma aguda (febre de Katayama) e crônica **hepatoesplênica com hipertensão portal** (fibrose de Symmers) → praziquantel.

Leishmaniose visceral (calazar): febre arrastada, **hepatoesplenomegalia**, pancitopenia, emagrecimento, criança ou imunossuprimido em área endêmica → **anfotericina B lipossomal** (primeira escolha em gestante, criança e imunossuprimido).

Leishmaniose tegumentar: úlcera de bordas elevadas e fundo granulomatoso, indolor, em área exposta.

Febre maculosa brasileira: contato com carrapato-estrela (área rural, cavalos), febre alta, cefaleia intensa, **exantema que acomete palmas e plantas** (2º–5º dia) → **doxiciclina imediata, sem aguardar confirmação sorológica** — letalidade alta se o tratamento for tardio.

Doença de Lyme-símile (Baggio-Yoshinari): síndrome brasileira transmitida por carrapatos do gênero *Amblyomma*, com eritema migratório, artralgia e sintomas neurológicos — reconhecida como entidade distinta da doença de Lyme americana.

PARTE I — INFECTOLOGIA

1.7 Seps, meningite e endocardite

Seps = disfunção orgânica ameaçadora à vida por resposta desregulada à infecção (**SOFA ≥ 2**). **Choque séptico** = necessidade de vasopressor para PAM ≥ 65 mmHg **com lactato > 2 mmol/L** apesar de reposição volêmica adequada.

Pacote da primeira hora: dosar lactato, **coletar hemoculturas antes de iniciar o antibiótico**, iniciar **antibiótico de amplo espectro, cristalóide 30 mL/kg** se hipotensão ou lactato ≥ 4 , iniciar **noradrenalina** se hipotensão persistente após volume.

Controle do foco infeccioso (drenar abscesso, remover cateter, desbridar) é determinante para o desfecho, tanto quanto o antibiótico.

Meningite bacteriana: febre, cefaleia, rigidez de nuca, alteração do sensório (a tríade completa é minoria dos casos — não excluir pela ausência).

Líquor: predomínio de **neutrófilos**, **glicose baixa**, proteína alta, lactato elevado.

Tratamento: **ceftriaxona** ($\pm$ vancomicina se suspeita de pneumococo resistente ou uso hospitalar recente); **dexametasona administrada antes ou junto da primeira dose de antibiótico** — reduz sequelas, principalmente na meningite pneumocócica.

TC de crânio antes da punção lombar apenas se: sinal neurológico focal, papiledema, imunossupressão, crise convulsiva recente, ou rebaixamento importante do sensório — do contrário, **não atrasar a punção**.

Quimioprofilaxia dos contatos íntimos (meningococo e Hib) com **rifampicina**. Notificação imediata.

Endocardite infecciosa: febre + sopro cardíaco novo (ou piora de sopro prévio) + fenômenos embólicos/imunológicos (petéquias, nódulos de Osler, lesões de Janeway, manchas de Roth, hemorragias em estilhaço).

Crítérios de Duke combinam achados clínicos, microbiológicos (hemoculturas seriadas) e ecocardiográficos (vegetação, abscesso, deiscência de prótese).

Fatores de risco: valvopatia prévia, prótese valvar, uso de drogas injetáveis, dispositivos intracardíacos, procedimentos dentários em paciente de risco.

Tratamento prolongado (4–6 semanas) com antibiótico dirigido ao agente; cirurgia se insuficiência cardíaca refratária, vegetação grande com risco embólico, infecção não controlada ou abscesso perivalvar.

PARTE I — INFECTOLOGIA

1.8 Infecções de pele e partes moles — ver também Dermatologia

Erisipela (bordas nítidas e elevadas, acometimento superficial da derme, febre) × **celulite** (bordas mal definidas, acometimento mais profundo) → penicilina/cefalexina. **Fasciíte necrotizante: dor desproporcional ao exame**, edema tenso, bolhas violáceas, crepitação, toxemia, evolução rápida — **emergência: desbridamento cirúrgico imediato** associado a antibiótico de amplo espectro; antibiótico isolado não salva.

PARTE I — INFECTOLOGIA

1.9 Outras infecções e imunização do adulto

Tétano: ferimento contaminado + esquema vacinal incompleto/desconhecido → **soro/imunoglobulina antitetânica + vacinação**, conforme o tipo de ferimento e o histórico vacinal; quadro clínico com trismo, rigidez, espasmos.

Botulismo: paralisia flácida **descendente**, sem febre, com disfunção autonômica; alimentar (conservas mal processadas) ou por ferida → soro antibotulínico.

Raiva: mordedura de animal, especialmente morcego, cão ou gato sem vacinação — **lavagem imediata da ferida com água e sabão** + soro/imunoglobulina + vacina, conforme classificação do acidente; **letalidade praticamente de 100%** após sintomas.

Influenza e COVID-19: vacinação anual e por campanha; síndromes respiratórias agudas graves são de notificação; oseltamivir em grupos de risco.

Imunização do adulto e do idoso: dT/dTpa a cada 10 anos, influenza anual (≥ 60 anos e grupos de risco), pneumocócicas (idoso e comorbidades), herpes-zóster (≥ 60 anos, conforme disponibilidade), hepatite B para não imunizados, febre amarela conforme área de risco.

PARTE II — CARDIOLOGIA

2.1 Hipertensão arterial

A Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025 (SBC/SBN/SBH) reclassificou os valores de pressão e universalizou a meta terapêutica.

Nova classificação (2025):

CATEGORIA	PAS		PAD
PA normal	< 120	e	< 80
Pré-hipertensão	120–139	e/ou	80–89
HAS estágio 1	140–159	e/ou	90–99
HAS estágio 2	160–179	e/ou	100–109
HAS estágio 3	≥ 180	e/ou	≥ 110

120/80 mmHg deixou de ser "normal" e agora é pré-hipertensão. É a mudança mais provável de aparecer em prova — se o material do candidato ainda descrever 120/80 como normal, está desatualizado.

Diagnóstico: confirmar com **MAPA (≥ 130/80 na média de 24h)** ou **MRPA (≥ 130/80)**, especialmente para diferenciar hipertensão do avental branco (alta no consultório, normal fora) de hipertensão mascarada (normal no consultório, alta fora — a mais perigosa por ser subdiagnosticada).

Meta terapêutica universal: < 130/80 mmHg para todos os pacientes hipertensos, independentemente de idade ou risco cardiovascular — a diretriz de 2025 aboliu a antiga meta mais frouxa para idosos, individualizando apenas em fragilidade importante, hipotensão ortostática ou expectativa de vida muito limitada.

Tratamento:

Mudança de estilo de vida sempre: dieta DASH, redução de sódio, perda de peso, atividade física, moderação do álcool, cessação do tabagismo.

Início com monoterapia: estágio 1 de baixo risco. **Início com combinação dupla:** estágio 1 de alto risco e estágios 2/3.

Primeira linha: IECA ou BRA, bloqueador de canal de cálcio e diurético tiazídico.

Betabloqueador agora entra como opção de primeira linha (monoterapia ou associação) quando há **indicação específica:** insuficiência cardíaca, doença coronariana, fibrilação atrial, paciente em diálise, ou mulher com desejo de engravidar.

Combinação proibida: IECA + BRA (sem benefício adicional e mais efeitos adversos).

Situações especiais:

Nomenclatura das crises hipertensivas foi revisada — mantém-se a distinção essencial:

- **Emergência hipertensiva:** PA muito elevada **com lesão aguda de órgão-alvo** (AVC, edema agudo de pulmão, síndrome coronariana aguda, dissecação de aorta, encefalopatia hipertensiva, eclâmpsia) → **medicação endovenosa em ambiente de terapia intensiva**, redução gradual (não normalizar de imediato).
- **Urgência hipertensiva:** PA elevada **sem lesão aguda de órgão-alvo** → medicação **oral**, redução em 24–48 horas. **Nifedipino sublingual é proscrito** (queda abrupta e imprevisível de PA, risco isquêmico).
- **Pseudocrise hipertensiva:** elevação da PA reativa a dor, ansiedade ou desconforto — tratar a causa, não a pressão em si.

Hipertensão secundária — suspeitar com início antes dos 30 ou depois dos 55 anos, HAS resistente, hipocalemia espontânea, sopro abdominal, ou piora abrupta do controle prévio. Causas mais comuns: **apneia obstrutiva do sono** (a mais prevalente), doença renal parenquimatosa, **hiperaldosteronismo primário**, estenose de artéria renal, feocromocitoma, coarctação da aorta, uso de substâncias (anticoncepcional, AINE, descongestionante, drogas ilícitas).

HAS resistente: PA não controlada com **3 fármacos em dose otimizada, incluindo um diurético** → investigar causa secundária e adesão; acrescentar **espironolactona** como quarto fármaco.

HAS refratária: não controlada com **5 ou mais fármacos**, incluindo um diurético e um antagonista mineralocorticoide.

PARTE II — CARDIOLOGIA

2.2 Dislipidemia e risco cardiovascular

Estratificação pelo **escore de risco global**, com categorias que já definem risco alto/muito alto independentemente do cálculo: doença aterosclerótica manifesta, diabetes com lesão de órgão-alvo, doença renal crônica avançada, LDL ≥ 190 mg/dL, hipercolesterolemia familiar.

Metas de LDL: risco muito alto **< 50**, alto **< 70**, intermediário **< 100**, baixo **< 130 mg/dL**.

Meta de colesterol não-HDL, agora explicitada como alvo secundário: redução $\geq 50\%$ no risco alto/muito alto/extremo, $\geq 30\%$ no risco baixo/intermediário — intensificar a terapia quando qualquer uma das metas não for atingida.

Lipoproteína(a) [Lp(a)]: recomenda-se dosar pelo menos uma vez na vida em todo adulto — níveis ≥ 50 mg/dL (ou ≥ 125 nmol/L) aumentam o risco de doença coronariana precoce e recorrente, mesmo com LDL controlado. Indicações específicas de dosagem: história familiar de doença coronariana precoce (< 55 anos em homens, < 65 anos em mulheres), hipercolesterolemia familiar, doença cardiovascular recorrente apesar de LDL controlado.

Estatina de alta potência (atorvastatina 40–80 mg, rosuvastatina 20–40 mg) para risco alto e muito alto; associar **ezetimiba** e, se necessário, **inibidor de PCSK9**.

Triglicerídeos > 500 mg/dL → tratar primeiro com **fibrato**, pelo risco de pancreatite aguda.

Efeitos adversos da estatina: mialgia, elevação de CPK, hepatotoxicidade — **dosar CPK apenas se houver sintomas**, não de rotina.

PARTE II — CARDIOLOGIA

2.3 Síndromes coronarianas agudas

Cenário típico: dor torácica opressiva, irradiada para MSE/mandíbula, associada a sudorese, náusea, com ou sem fatores de risco cardiovasculares — mas a prova também cobra **apresentações atípicas** (diabéticos, idosos e mulheres podem ter apenas dispneia, fadiga ou dor epigástrica).

Com supra de ST: reperfusão o mais rápido possível — **angioplastia primária em até 120 minutos** do primeiro contato médico; se indisponível nesse prazo, **trombólise em até 30 minutos**, com transferência posterior para angiografia.

Sem supra de ST: estratificação de risco (**escore GRACE**), dupla antiagregação plaquetária, anticoagulação, estatina de alta potência, betabloqueador (se sem contraindicação); estratégia invasiva precoce conforme risco.

Troponina ultrasensível seriada é o biomarcador padrão — sempre interpretar junto ao quadro clínico e ao ECG, nunca isoladamente.

Contraindicações ao nitrato: uso recente de inibidor de fosfodiesterase (sildenafil e correlatos), hipotensão, e **infarto de ventrículo direito** (supradesnível em V3R/V4R, hipotensão com pulmões limpos → repor volume, nunca nitrato).

Complicações mecânicas do IAM: ruptura de músculo papilar (insuficiência mitral aguda), ruptura de septo interventricular, ruptura de parede livre (tamponamento) — pensar quando há deterioração súbita nos primeiros dias.

Angina estável: dor previsível ao esforço, aliviada com repouso/nitrato; estratificar com teste ergométrico ou cintilografia; tratamento otimizado antes de intervenção, salvo alto risco.

PARTE II — CARDIOLOGIA

2.4 Insuficiência cardíaca

Classificação por **fração de ejeção**: reduzida ($\leq 40\%$), levemente reduzida (41–49%), preservada ($\geq 50\%$); e por **classe funcional NYHA** (I a IV).

Os pilares farmacológicos da ICFer (iniciar precocemente, em conjunto, não sequencialmente):

1. **IECA/BRA, ou preferencialmente sacubitril-valsartana**
2. **Betabloqueador** (carvedilol, bisoprolol, succinato de metoprolol)
3. **Antagonista mineralocorticoide** (espironolactona, eplerenona)
4. **Inibidor de SGLT2** (dapagliflozina, empagliflozina) — benefício independe de diabetes

IC aguda descompensada: classificar por perfil clínico — "quente-úmido" (congestão sem hipoperfusão) → **diurético e vasodilatador**; "frio-úmido" (congestão com hipoperfusão) → **inotrópico**, considerando suporte circulatório se refratário.

BNP/NT-proBNP: útil no diagnóstico diferencial da dispneia aguda; valores muito baixos afastam IC como causa.

ICFep: manejo focado em comorbidades (HAS, obesidade, fibrilação atrial), diuréticos para congestão, e SGLT2 com benefício demonstrado também nesse fenótipo.

PARTE II — CARDIOLOGIA

2.5 Arritmias

Fibrilação atrial — ritmo irregularmente irregular, ausência de onda P organizada.

A Diretriz Brasileira de Fibrilação Atrial 2025 substituiu o escore CHA₂DS₂-VASc pelo CHA₂DS₂-VA — o sexo feminino deixou de ser critério de pontuação.

Anticoagular se escore ≥ 2 ; escore = 1 admite individualização e decisão compartilhada; escore = 0 não deve ser anticoagulado.

Situações que indicam anticoagulação **independentemente do escore**: cardiomiopatia hipertrófica, amiloidose cardíaca, hipertireoidismo com FA.

HAS-BLED avalia risco de sangramento e ajuda a identificar fatores modificáveis, mas **não contraindica** a anticoagulação por si só.

DOACs são preferíveis a varfarina, exceto em **prótese valvar mecânica e estenose mitral moderada/grave**, onde se usa **varfarina** com **INR alvo 2,0–3,0**, mantido em faixa terapêutica por mais de 70% do tempo.

FA aguda estável: a nova diretriz reduziu a janela seguramente considerada para cardioversão sem necessidade de exclusão prévia de trombo — **cardioverter se início há menos de 24 horas** (antes eram 48h) **e baixo risco tromboembólico** (etiologia não valvar, sem evento embólico prévio, CHA₂DS₂-VA < 2). Fora dessa janela ou em alto risco: anticoagular e/ou fazer ecocardiograma transesofágico antes de cardioverter.

FA instável (hipotensão, angina, IC aguda, alteração do sensorio) → **cardioversão elétrica sincronizada imediata**, independentemente do tempo de início.

Antiagregação isolada (mono ou dupla) **não é recomendada** para prevenção de AVC na FA.

Outras arritmias:

Flutter atrial: ritmo "em serrate" nas derivações inferiores, frequentemente com condução 2:1; mesmos princípios de anticoagulação da FA.

Extrassístoles (atriais e ventriculares): geralmente benignas em coração estruturalmente normal; investigar se sintomáticas ou frequentes.

Taquicardia supraventricular paroxística: início e término súbitos; estável → **manobra vagal seguida de adenosina**; instável → cardioversão sincronizada.

Taquicardia ventricular: QRS largo; instável → cardioversão; estável → antiarrítmico (amiodarona).

Síndrome do QT longo e síndrome de Brugada: causas de morte súbita em jovens, muitas vezes hereditárias — suspeitar em síncope de esforço/emocional ou história familiar de morte súbita.

Bradiarritmias: bloqueio AV de 2º grau Mobitz II e **bloqueio AV total** são indicação de **marca-passo definitivo**; atropina para bradicardia sintomática aguda com QRS estreito.

PARTE II — CARDIOLOGIA

2.6 Valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias

Estenose aórtica: tríade clássica **angina, síncope e dispneia** ao esforço; sopro sistólico ejetivo em foco aórtico irradiado para carótidas → troca valvar cirúrgica ou **TAVI** quando sintomática ou com disfunção ventricular.

Insuficiência mitral: sopro holossistólico em foco mitral irradiado para axila; aguda (ruptura de cordoalha/papilar) é emergência.

Estenose mitral: história de febre reumática, sopro diastólico em ruflar, associação frequente com fibrilação atrial e fenômenos tromboembólicos.

Febre reumática: causa clássica de valvopatia em jovens no Brasil; ver critérios de Jones no bloco de Reumatologia. **Profilaxia secundária com penicilina benzatina a cada 21 dias** previne novos surtos e progressão da lesão valvar.

Miocardiopatia dilatada: câmaras dilatadas com disfunção sistólica; causas incluem isquêmica, chagásica, alcoólica, periparto e idiopática.

Miocardiopatia hipertrófica: principal causa de morte súbita em atletas jovens; sopro que aumenta com manobra de Valsalva (diferencia da estenose aórtica, que diminui).

Pericardite aguda: dor torácica pleurítica que **piora deitado e melhora sentado e inclinado para frente**, atrito pericárdico, supradesnível difuso de ST **côncavo** no ECG (sem imagem em espelho) → AINE + colchicina.

Tamponamento cardíaco: **tríade de Beck** (hipotensão, turgência jugular, abafamento de bulhas), pulso paradoxal, ecocardiograma com colapso diastólico de câmaras direitas → **pericardiocentese/janela pericárdica**.

PARTE II — CARDIOLOGIA

2.7 Doença arterial periférica, aneurismas e tromboembolismo venoso

Doença arterial periférica: claudicação intermitente, **índice tornozelo-braço (ITB) < 0,9**; isquemia crítica com dor em repouso ou lesão trófica exige revascularização. Ver detalhes cirúrgicos no Rapid Review de Cirurgia.

Aneurisma de aorta abdominal: rastreamento por USG recomendado em **homens de 65–75 anos tabagistas**; correção eletiva a partir de 5,5 cm ou crescimento rápido.

TVP: escore de Wells, D-dímero (bom valor preditivo negativo), USG com Doppler venoso confirma; anticoagulação por, no mínimo, 3 meses (mais tempo se fator de risco persistente ou evento não provocado).

TEP: dispneia súbita, dor pleurítica, taquicardia; angio-TC confirma; **trombólise se instabilidade hemodinâmica**; considerar filtro de veia cava se contraindicação à anticoagulação com TVP proximal.

PARTE II — CARDIOLOGIA

2.8 Avaliação cardiovascular perioperatória

Estratificação pelo **índice de risco cardíaco revisado (Lee)**: cirurgia de alto risco, doença coronariana, insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, diabetes em insulina, creatinina elevada.

Capacidade funcional estimada em METs orienta a necessidade de investigação adicional — abaixo de 4 METs (não sobe um lance de escada sem parar) pesa a favor de mais exames antes de cirurgias de risco intermediário/alto.

Manejo de antiagregantes e anticoagulantes no perioperatório: individualizar conforme o risco trombótico da condição de base e o risco hemorrágico do procedimento — geralmente suspender anticoagulante alguns dias antes de cirurgias de alto risco de sangramento, com ponte conforme o caso.

Betabloqueador **não deve ser iniciado no dia da cirurgia** em paciente virgem de tratamento (risco de bradicardia/hipotensão perioperatória); manter se já em uso crônico.

PARTE III — ENDOCRINOLOGIA

3.1 Diabetes mellitus

Diagnóstico (dois exames alterados em dias diferentes, ou um exame alterado com sintomas clássicos e glicemia casual ≥ 200):

EXAME	DIABETES	PRÉ-DIABETES
Glicemia de jejum	≥ 126 mg/dL	100–125
Glicemia 2h no TOTG 75g	≥ 200 mg/dL	140–199
HbA1c	$\geq 6,5\%$	5,7–6,4%

O que mudou no PCDT DM2 (fevereiro de 2026): o Ministério da Saúde **incorporou ao SUS as insulinas análogas de ação prolongada e de ação rápida**, com normatização explícita para prescrição e acompanhamento na Atenção Primária — até então, o SUS ofertava predominantemente insulina humana (NPH e regular).

Tratamento do DM2:

Metformina + mudança de estilo de vida para a quase totalidade dos pacientes, salvo contraindicação (TFG < 30 , acidose, insuficiência hepática grave).

Escolha do segundo fármaco conforme o perfil de risco do paciente — este raciocínio é frequentemente cobrado como "qual a melhor escolha para este paciente":

- **Doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida** → **análogo de GLP-1** ou **inibidor de SGLT2**, com benefício cardiovascular comprovado.
- **Insuficiência cardíaca ou doença renal crônica** → **inibidor de SGLT2** é a escolha preferencial.
- **Obesidade associada** → **análogo de GLP-1**, pelo efeito sobre o peso.
- Custo como limitante, sem as comorbidades acima → sulfonilureia como alternativa.

Meta geral de HbA1c $< 7\%$, individualizada: mais frouxa (7,5–8%) em idoso frágil, expectativa de vida limitada ou hipoglicemias frequentes; mais estrita em jovens recém-diagnosticados sem comorbidade.

Nefroproteção reforçada: IECA/BRA indicados para **todo paciente com TFG < 60 mL/min/1,73m², mesmo sem hipertensão ou albuminúria; não suspender** essas drogas apenas por queda isolada da TFG após início (conduta associada a pior desfecho). **Finerenona** tem recomendação formal para nefroproteção em pacientes com albuminúria e TFG ≥ 25 , contemplando DM1 e DM2. **Semaglutida** tem recomendação forte para retardar a progressão da doença renal do diabético em pacientes com relação albumina/creatinina > 100 mg/g.

Insulinização: indicada quando HbA1c muito elevada ao diagnóstico, sintomas catabólicos, gestação, ou falha da terapia oral otimizada — iniciar com **insulina basal (NPH ou análoga) ao deitar** e titular pela glicemia de jejum.

Diabetes tipo 1 (novo capítulo da diretriz): meta de HbA1c entre 7,0% e 7,5%.

Rastreamento de complicações crônicas:

Retinopatia: fundoscopia **no diagnóstico do DM2**; após **5 anos** de diagnóstico no DM1; depois, anualmente.

Nefropatia: relação albumina/creatinina e creatinina sérica anuais.

Neuropatia e pé diabético: exame dos pés a cada consulta, **monofilamento de 10 g** e diapasão de 128 Hz.

Complicações agudas:

	CETOACIDOSE DIABÉTICA	ESTADO HIPERGLICÊMICO HIPEROSMOLAR
Perfil	DM1, jovem, instalação rápida (horas)	DM2, idoso, dias de evolução
Glicemia	Tipicamente > 250	Frequentemente > 600
pH / cetonas	pH $< 7,3$, cetonemia/cetonúria	pH próximo do normal, cetose discreta
Osmolaridade	Variável	Tipicamente > 320 mOsm/kg
Manejo	Volume + insulina EV em infusão contínua + reposição de potássio; bicarbonato reservado a pH $< 6,9$	Volume mais generoso (déficit maior), insulina, correção lenta do sódio corrigido

Regras práticas que caem: repor potássio antes de iniciar insulina se K $< 3,3$ mEq/L (a insulina desloca potássio para dentro da célula e pode precipitar arritmia); **não suspender a insulina abruptamente** quando a glicemia atinge ~ 200 – 250 mg/dL — acrescentar soro glicosado e manter a insulina até resolver a cetose/acidose.

Hipoglicemia: tríade de Whipple (sintomas + glicemia baixa + melhora com correção). Consciente → carboidrato oral de absorção rápida; inconsciente ou incapaz de deglutir → **glicose hipertônica EV** ou glucagon IM/SC.

PARTE III — ENDOCRINOLOGIA

3.2 Tireoide

	HIPOTIREOIDISMO	HIPERTIREOIDISMO
Laboratório	TSH alto, T4 livre baixo	TSH baixo, T4 livre alto
Causa mais comum	Tireoidite de Hashimoto (anti-TPO positivo)	Doença de Graves (TRAb positivo, bócio difuso, oftalmopatia)
Clínica	Fadiga, ganho de peso, constipação, pele seca e fria, bradicardia, reflexos lentificados , intolerância ao frio	Perda de peso com apetite preservado, tremor fino, taquicardia/palpitações, intolerância ao calor, hiperdefecação, irritabilidade
Tratamento	Levotiroxina em jejum (30–60 min antes do café), ajuste de dose por TSH a cada 6–8 semanas	Metimazol (propiltiouracil no 1º trimestre da gestação , pelo menor risco teratogênico nessa fase), betabloqueador sintomático, iodo radioativo, cirurgia

Subclínico: TSH alterado com **T4 livre normal**. Tratar hipotireoidismo subclínico se **TSH > 10 mUI/L**, ou entre 4,5–10 com sintomas, anti-TPO positivo, dislipidemia, gestação ou desejo de engravidar.

Tireoidite subaguda (De Quervain): dor cervical após infecção viral, **VHS muito elevada**, tireotoxicose transitória com **captação de iodo baixa** (diferença chave frente ao Graves) → AINE ou corticoide, sem antitireoidiano.

Tireoidite pós-parto: fase hipertireóidea seguida de hipotireóidea nos meses após o parto, geralmente autolimitada.

Crise tireotóxica ("tempestade tireoidiana"): febre alta, agitação/delirium, taquiarritmia, disfunção multissistêmica → propiltiouracil + betabloqueador + corticoide + iodo (administrado após a tionamida, para não alimentar a síntese hormonal).

Coma mixedematoso: hipotermia, bradicardia, rebaixamento do sensório em hipotireóideo grave → levotiroxina endovenosa + hidrocortisona (cobrir possível insuficiência adrenal concomitante).

Nódulo tireoidiano e câncer de tireoide: ver Rapid Review de Cirurgia para a investigação com USG/TI-RADS, PAAF/Bethesda e tipos histológicos.

PARTE III — ENDOCRINOLOGIA

3.3 Adrenal

Síndrome de Cushing: obesidade centrípeta, estrias violáceas largas, fragilidade capilar (equimoses fáceis), miopatia proximal, hipertensão e diabetes de difícil controle, face em lua cheia, giba dorsal. **A causa mais comum no geral é exógena/iatrogênica** (uso crônico de corticoide). Rastreo: **cortisol salivar noturno, cortisol livre urinário de 24 horas**, ou **teste de supressão com 1 mg de dexametasona**.

Insuficiência adrenal: fadiga, hipotensão, perda de peso; **hiperpigmentação cutaneomucosa** na forma primária (doença de Addison, por elevação do ACTH); **hiponatremia com hipercalemia** na primária (perda de aldosterona) — na secundária (hipofisária), o eixo mineralocorticoide costuma estar preservado. Diagnóstico com cortisol basal e teste de estímulo com ACTH.

Crise adrenal: emergência — **hidrocortisona endovenosa em bólus + reposição volêmica agressiva**, imediatamente, sem aguardar confirmação laboratorial se a suspeita for forte.

Feocromocitoma: hipertensão paroxística ou resistente, cefaleia, sudorese e palpitação em crises (a tríade clássica) → metanefrinas plasmáticas/urinárias; preparo pré-operatório obrigatório com **alfabloqueio antes de betabloqueio** (nunca o inverso, risco de crise hipertensiva grave).

Incidentaloma adrenal: massa encontrada incidentalmente em exame de imagem → avaliar funcionalidade hormonal (cortisol, metanefrinas, aldosterona/renina se hipertenso/hipocalêmico) e características de imagem sugestivas de malignidade antes de decidir conduta.

Hiperaldosteronismo primário: hipertensão associada a **hipocalemia espontânea** (nem sempre presente) e HAS resistente → relação aldosterona/renina como rastreo.

PARTE III — ENDOCRINOLOGIA

3.4 Hipófise

Prolactinoma: galactorreia, amenorreia/irregularidade menstrual na mulher, disfunção erétil e diminuição da libido no homem; prolactina elevada (excluir uso de antipsicóticos, hipotireoidismo e gestação antes de rotular como tumoral) → **agonista dopaminérgico (cabergolina)** é o tratamento de primeira linha, inclusive para tumores grandes.

Acromegalia: crescimento de extremidades, alterações faciais progressivas, sudorese excessiva, artralgias, associação com diabetes e hipertensão → **IGF-1** como rastreio, confirmação com TOTG sem supressão do GH.

Hipopituitarismo: perda hormonal seguindo tipicamente a ordem GH → gonadotrofinas → TSH → ACTH; causas incluem tumores, cirurgia, radioterapia, apoplexia hipofisária e **síndrome de Sheehan** (necrose hipofisária pós-hemorragia obstétrica grave).

Diabetes insípido: poliúria com urina muito diluída, apesar de hiperosmolaridade sérica — central (falta de ADH, responde à desmopressina) × nefrogênico (resistência renal ao ADH, não responde).

SIADH: hiponatremia com urina concentrada em euvolemia, causas incluem neoplasias (especialmente pulmão), doenças do SNC e fármacos (ISRS, carbamazepina) → restrição hídrica; correção lenta do sódio (risco de mielinólise pontina se corrigido rápido demais).

PARTE III — ENDOCRINOLOGIA

3.5 Paratireoide e metabolismo ósseo

Hiperparatireoidismo primário: **cálcio elevado com PTH elevado ou inapropriadamente normal**; a maioria é assintomática, achado em exames de rotina; adenoma único na maioria dos casos.

Hipoparatireoidismo: mais comumente pós-cirúrgico (tireoidectomia) — hipocalcemia com **sinais de Chvostek e Trousseau**, parestesias periorais, tetania.

Osteoporose: densitometria óssea com **T-score $\leq -2,5$** ; rastrear mulheres ≥ 65 anos e homens ≥ 70 , ou mais cedo com fatores de risco. **Fratura por fragilidade define osteoporose independentemente do valor da densitometria**. Tratamento: cálcio, vitamina D e **bisfosfonato** como primeira linha.

Doença de Paget óssea: remodelação óssea desordenada, dor óssea, deformidades, **fosfatase alcalina muito elevada** com cálcio normal.

PARTE III — ENDOCRINOLOGIA

3.6 Obesidade

Classificação por IMC (≥ 30 = obesidade); avaliar também circunferência abdominal e comorbidades associadas (síndrome metabólica, apneia do sono, esteatose hepática, osteoartrite).

Farmacoterapia: análogos de GLP-1 (liraglutida, semaglutida) e associações (tirzepatida, quando disponível) são a primeira linha farmacológica atual, com perda ponderal expressiva e benefício cardiometabólico; orlistate e sibutramina seguem como alternativas.

Indicações específicas conforme comorbidade: diabetes tipo 2 → GLP-1; diabetes + doença renal crônica → semaglutida com benefício renal comprovado.

Cirurgia bariátrica: IMC ≥ 40 , ou ≥ 35 com comorbidade relevante — ver detalhes técnicos e complicações no Rapid Review de Cirurgia.

PARTE IV — GASTROENTEROLOGIA E HEPATOLOGIA

4.1 DRGE, dispepsia e úlcera péptica

DRGE: pirose e regurgitação; diagnóstico **clínico**, e a prova terapêutica com IBP confirma na maioria dos casos.

Endoscopia indicada apenas com sinais de alarme: disfagia, odinofagia, perda de peso, anemia, sangramento digestivo, vômitos persistentes, massa palpável, história familiar de câncer gástrico, idade > 40–45 anos com sintomas novos.

Tratamento: medidas comportamentais (elevar a cabeceira, evitar deitar logo após as refeições, perda de peso, evitar gatilhos) + **IBP por 8 semanas**.

Esôfago de Barrett: metaplasia intestinal do epitélio esofágico distal → vigilância endoscópica periódica pelo risco de adenocarcinoma de esôfago.

Helicobacter pylori — indicações de pesquisa e erradicação: **úlcera péptica** (ativa ou cicatrizada), linfoma MALT gástrico, dispepsia funcional investigada, uso crônico de AINE/AAS, história familiar de primeiro grau com câncer gástrico, após ressecção de câncer gástrico precoce.

Esquema clássico: **IBP + amoxicilina + claritromicina por 14 dias** (esquemas alternativos com bismuto em áreas de resistência elevada à claritromicina).

Controle de erradicação 4 semanas após o término do tratamento, com **teste respiratório da ureia ou antígeno fecal** — a sorologia não serve para controle de cura (permanece positiva mesmo após erradicação).

Úlcera péptica: dor epigástrica — a duodenal tipicamente **alivia com a alimentação** e desperta à noite; a gástrica pode **piorar com a alimentação**. Complicações possíveis: **hemorragia** (a mais comum), perfuração, obstrução pilórica. **Toda úlcera gástrica exige biópsia e controle endoscópico de cicatrização** (excluir malignidade) — a duodenal não precisa de controle de rotina, salvo atipia.

Hemorragia digestiva alta: estabilização inicial, **IBP endovenoso, endoscopia em até 24 horas**, classificação de **Forrest** orientando terapia endoscópica (Ia a IIb exigem intervenção); variz esofágica sangrante → **droga vasoativa (terlipressina/octreotide) + ligadura elástica + antibiótico profilático (ceftriaxona)**. Meta transfusional restritiva (hemoglobina em torno de 7 g/dL, salvo cardiopata).

PARTE IV — GASTROENTEROLOGIA E HEPATOLOGIA

4.2 Doenças inflamatórias intestinais e diarreia crônica

	DOENÇA DE CROHN	RETICOLITE ULCERATIVA
Extensão	Da boca ao ânus, saltada	Reto e cólon, contínua
Camada	Transmural	Mucosa e submucosa
Achados típicos	Fístulas, estenoses, doença perianal	Sangramento retal , tenesmo
Complicação temida	Abscessos, fístulas, obstrução	Megacólon tóxico
Risco de câncer	Aumentado, sobretudo colônico	Aumentado, proporcional à extensão e duração

Manifestações extraintestinais em ambas: artrite periférica, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, uveíte, colangite esclerosante primária (mais associada à RCU).

Diagnóstico: colonoscopia com biópsia, calprotectina fecal como marcador de atividade e triagem.

Tratamento escalonado: aminossalicilatos (mais eficazes na RCU), corticoide para indução de remissão, imunomoduladores e **biológicos (anti-TNF e outros)** para manutenção e casos moderados a graves.

Diarreia crônica (> 4 semanas): investigar causas osmóticas, secretórias, inflamatórias e por má absorção — **doença celíaca**, parasitoses, doença inflamatória intestinal, insuficiência pancreática exócrina, hipertireoidismo, síndrome do intestino irritável. **Doença celíaca**: diarreia crônica, distensão, anemia ferropriva refratária, dermatite herpetiforme → **anti-transglutaminase IgA + IgA total** (dosar IgA total para excluir falso-negativo por deficiência seletiva de IgA); confirmação por biópsia duodenal, **realizada com o paciente ainda ingerindo glúten**. **Síndrome do intestino irritável**: critérios de **Roma IV** — dor abdominal recorrente associada à defecação e a mudanças na frequência/forma das fezes, **sem sinais de alarme** (perda de peso, sangramento, anemia, início após os 50 anos).

PARTE IV — GASTROENTEROLOGIA E HEPATOLOGIA

4.3 Fígado — nomenclatura atualizada e hepatopatias

Mudança de nomenclatura internacional (2023), já adotada por sociedades brasileiras: a antiga "**doença hepática gordurosa não alcoólica**" (DHGNA/NAFLD) foi substituída por **doença hepática esteatótica associada a disfunção metabólica (MASLD)**; a antiga esteato-hepatite não alcoólica (EHNA/NASH) virou **MASH**. A Sociedade Brasileira de Diabetes já adota o termo em português "**doença hepática esteatótica metabólica (DHEM)**".

Diagnóstico de MASLD: esteatose hepática (por imagem, biópsia ou biomarcador) **associada a pelo menos 1 dos 5 critérios cardiometabólicos** (obesidade/sobrepeso, glicemia alterada/diabetes, hipertensão, dislipidemia com HDL baixo ou triglicerídeos altos).

MetALD: nova categoria intermediária para pacientes com MASLD que também consomem álcool em quantidade moderada (140–350 g/semana em mulheres, 210–420 g/semana em homens) — sem preencher critério para doença hepática alcoólica pura.

Mais de 95% dos pacientes antes rotulados como NAFLD preenchem os novos critérios de MASLD — a mudança é essencialmente de nomenclatura e de critérios diagnósticos positivos, não uma nova doença.

A **fibrose hepática segue sendo o principal fator prognóstico**, independentemente do nome adotado.

Outras hepatopatias a lembrar (temas adjacentes):

Hepatite autoimune: mulher jovem, transaminases elevadas, hipergamaglobulinemia, autoanticorpos (FAN, anti-músculo liso) → corticoide ± azatioprina.

Hemocromatose hereditária: sobrecarga de ferro, cirrose, diabetes bronzeado, cardiomiopatia, artropatia — ferritina e saturação de transferrina elevadas; tratamento com flebotomias terapêuticas.

Doença de Wilson: jovem com hepatopatia + sintomas neuropsiquiátricos + **anel de Kayser-Fleischer** — ceruloplasmina baixa; quelante de cobre.

Deficiência de alfa-1 antitripsina: hepatopatia e enfisema pulmonar precoce, especialmente em não tabagistas jovens.

Cirrose e suas complicações:

Ascite: paracentese diagnóstica com **GASA (gradiente albumina soro-ascite) $\geq 1,1$ g/dL** indica hipertensão portal. Tratamento: restrição de sódio + **espironolactona associada a furosemida**.

Peritonite bacteriana espontânea: ≥ 250 **polimorfonucleares/mm³** no líquido ascítico → **cefotaxima ou ceftriaxona + albumina** (a albumina reduz o risco de síndrome hepatorenal); profilaxia secundária com norfloxacin.

Encefalopatia hepática: alteração do nível de consciência e comportamento em cirrótico → **lactulose** e rifaximina; sempre procurar o fator precipitante (infecção, sangramento digestivo, constipação, distúrbio eletrolítico, uso de sedativo).

Síndrome hepatorenal: insuficiência renal funcional em cirrótico com ascite refratária, sem outra causa identificável → terlipressina/albumina; diagnóstico de exclusão.

Varizes esofágicas: rastreamento por endoscopia no cirrótico; profilaxia primária do primeiro sangramento com **betabloqueador não seletivo ou ligadura elástica**.

Rastreamento de carcinoma hepatocelular: ultrassonografia semestral ($\pm$ alfafetoproteína) em todo cirrótico.

Classificações prognósticas: **Child-Pugh** e **MELD**, usadas para estimar gravidade e priorizar transplante.

PARTE IV — GASTROENTEROLOGIA E HEPATOLOGIA

4.4 Pâncreas

Pancreatite aguda: ver detalhamento completo no Rapid Review de Cirurgia — diagnóstico com 2 de 3 critérios (dor típica, enzimas $\geq 3\times$ o limite, imagem compatível), hidratação com Ringer lactato, dieta oral precoce, antibiótico reservado à necrose infectada. **Pancreatite crônica:** dor abdominal recorrente, **esteatorreia**, perda de peso, diabetes secundário, calcificações pancreáticas em imagem → **reposição de enzimas pancreáticas** às refeições, suporte nutricional, abstinência alcoólica (principal causa), analgesia escalonada.

PARTE V — PNEUMOLOGIA

5.1 Asma

Diagnóstico: sintomas variáveis (sibilância, dispneia, aperto torácico, tosse) + **limitação variável ao fluxo aéreo** — espirometria com **VEF1/CVF reduzido e resposta ao broncodilatador (aumento do VEF1 $\geq$ 12% e 200 mL)**.

O GINA 2026 consolida a virada iniciada em revisões anteriores: não existe mais tratamento de resgate só com SABA (broncodilatador de curta duração isolado), em nenhuma faixa etária — inclusive crianças de 6 a 11 anos.

Trilha 1 (preferencial), em todas as etapas: corticoide inalatório + formoterol (CI-formoterol) como aliviador, seja no esquema **AIR** (alívio anti-inflamatório isolado, para os sintomas leves) ou **MART** (manutenção e alívio com a mesma combinação).

Trilha 2: CI+SABA de manutenção regular, com SABA à parte para alívio — reservado a quem não pode ou não aceita o Trilha 1.

Asma grave (step 5): terapias biológicas guiadas por biomarcadores tipo 2 (eosinófilos, FeNO); **tripla terapia inalatória (CI-LABA-LAMA)**, com a associação budesonida-formoterol-glicopirrônio validada para $\geq$ 12 anos.

Controle e classificação (últimas 4 semanas): sintomas diurnos $> 2\times$ /semana, despertar noturno, uso de resgate $> 2\times$ /semana, limitação de atividades — 0 = controlada; 1–2 = parcialmente controlada; 3–4 = **não controlada**.

Manejo da crise (novos fluxogramas do GINA 2026, com metas mais conservadoras):

Alvo de saturação: 92–95% em $\geq$ 6 anos (suplementar O_2 apenas se $SatO_2 < 92\%$); em < 5 anos, o alvo de suplementação é **$< 92\%$** .

Doses de SABA mais conservadoras — evitar excesso, pelo risco de **acidose láctica por toxicidade**, que pode ser confundida com piora da asma e levar a um ciclo de superdosagem.

Budesonida-formoterol passa a ser opção também na crise leve, ao lado do salbutamol tradicional.

Nova classificação de gravidade da crise: leve (fala frases completas, FR normal/discretamente elevada, $SatO_2 \geq 94\%$) → moderada (aumento de FR e FC, uso leve de musculatura acessória, $SatO_2$ mínima 92%) → grave/com risco de vida (incapaz de falar frases completas, dificuldade para beber ou ficar deitado, FR > 30 , **$SatO_2 < 92\%$** , pico de fluxo $< 50\%$ do previsto; sonolência, confusão, cianose ou **tórax silencioso** = risco iminente de vida).

Corticoide oral na crise moderada/grave: prednisona 40–50 mg por 5–7 dias.

Se houver sinais de anafilaxia associados à crise de asma, administrar adrenalina antes dos broncodilatadores.

$PaCO_2$ normal ou elevada em crise grave, com taquipneia, indica fadiga da musculatura respiratória → indicação de via aérea avançada.

PARTE V — PNEUMOLOGIA

5.2 DPOC

Diagnóstico: tabagismo (ou outra exposição relevante), dispneia progressiva, tosse produtiva crônica; **espirometria com VEF1/CVF < 0,70 pós-broncodilatador** confirma limitação **não totalmente reversível**.

Classificação por sintomas (**mMRC/CAT**) e histórico de exacerbações prévias → grupos **A, B e E** (o grupo E reúne quem exacerbou com frequência/gravidade, independentemente da carga de sintomas).

GOLD 2026 refina o manejo das exacerbações moderadas, tornando o ajuste terapêutico mais individualizado conforme sintomas e risco.

Tratamento farmacológico de manutenção: **broncodilatadores de longa duração (LAMA/LABA)** como base; **corticoide inalatório associado se eosinofilia sanguínea (geralmente > 300) ou exacerbações frequentes**, sobretudo no grupo E.

A cessação do tabagismo é a única medida, junto da oxigenoterapia na hipoxemia grave, que muda a história natural da doença — sempre a resposta correta quando a questão pede "a conduta mais importante".

Oxigenoterapia domiciliar prolongada: $\text{PaO}_2 \leq 55 \text{ mmHg}$ ou $\text{SatO}_2 \leq 88\%$ em repouso; ou PaO_2 56–59 com evidência de cor pulmonale ou policitemia.

Exacerbação aguda: broncodilatador de curta duração, **corticoide sistêmico por 5 dias**, antibiótico se aumento da purulência do escarro associado a aumento do volume/dispneia; **ventilação não invasiva reduz mortalidade** na exacerbação com acidose respiratória.

Reabilitação pulmonar, vacinação (influenza, pneumocócica, covid-19) e educação em saúde são pilares reforçados na atualização.

PARTE V — PNEUMOLOGIA

5.3 Pneumonia e derrame pleural

CURB-65 (confusão, ureia > 43 mg/dL, FR $\geq$ 30, PA sistólica < 90 ou diastólica $\leq$ 60, idade $\geq$ 65): 0–1 ponto → ambulatorial; 2 → considerar internação; $\geq$ 3 → internação, avaliar UTI.

Tratamento ambulatorial: **amoxicilina ± macrolídeo**; internado: **betalactâmico + macrolídeo**, ou quinolona respiratória isolada.

Pneumonia aspirativa: contexto de alcoolismo, disfagia ou rebaixamento de consciência; acomete tipicamente **segmentos posteriores e basais** (decúbito dorsal) — cobrir anaeróbios no esquema.

Derrame pleural — critérios de Light definem exsudato: proteína pleural/sérica > 0,5, LDH pleural/sérica > 0,6, ou LDH pleural > 2/3 do limite superior sérico normal.

- **Derrame parapneumônico complicado/empiema** (pH < 7,2, glicose baixa, presença de bactéria/pus) → **drenagem torácica**.
- Exsudato linfocítico com **ADA elevada** sugere etiologia tuberculosa.

PARTE V — PNEUMOLOGIA

5.4 Doenças intersticiais e hipertensão pulmonar

Fibrose pulmonar idiopática: dispneia progressiva, **estertores em velcro** nas bases, padrão em "vidro fosco/faveolamento" na TC de alta resolução; prognóstico reservado, antifibróticos retardam a progressão.

Pneumoconioses: silicose (exposição a sílica — mineração, jateamento), asbestose (amianto, risco de mesotelioma e câncer de pulmão); notificação compulsória como doença relacionada ao trabalho.

Sarcoidose: adenopatia hilar bilateral, granulomas não caseosos, pode acometer múltiplos órgãos; muitos casos regredem espontaneamente.

Hipertensão pulmonar: dispneia progressiva com sinais de sobrecarga de câmaras direitas; ecocardiograma para rastreio, cateterismo direito para confirmação; classificação por grupos etiológicos (1 a 5) orienta o tratamento.

PARTE V — PNEUMOLOGIA

5.5 Apneia obstrutiva do sono

Ronco, pausas respiratórias presenciadas, sonolência diurna excessiva, associação com obesidade e **hipertensão resistente**.

Polissonografia confirma e gradua pelo índice de apneia-hipopneia; **CPAP** é o tratamento de primeira linha nos casos moderados a graves.

PARTE V — PNEUMOLOGIA

5.6 Nódulo pulmonar, tromboembolismo e câncer de pulmão

Nódulo pulmonar solitário: avaliar tamanho, bordas (espiculadas são suspeitas), padrão de calcificação (central, laminar ou "em pipoca" sugerem benignidade), taxa de crescimento e fatores de risco (tabagismo, idade) para decidir entre seguimento por imagem ou investigação invasiva.

TEP: ver bloco de Cardiologia (item 16) — dispneia súbita, dor pleurítica, **escore de Wells**, angio-TC confirma; trombólise se instabilidade hemodinâmica.

Câncer de pulmão: tabagismo é o principal fator de risco; tosse persistente, hemoptise, perda de peso; **síndromes paraneoplásicas** — SIADH e síndrome de Cushing ectópica no tipo pequenas células, hipercalcemia por PTHrp no tipo escamoso.

PARTE VI — NEUROLOGIA

6.1 Cefaleias

	ENXAQUECA	TENSIONAL	EM SALVAS
Característica	Pulsátil, unilateral , moderada a forte	Em peso/aperto, bilateral, leve a moderada	Excruciante, periorbital , estritamente unilateral
Duração	4–72 horas	30 min a 7 dias	15–180 min, em surtos (várias vezes ao dia por semanas)
Sintomas associados	Náusea, fotofobia e fonofobia , piora com esforço físico; aura em cerca de 25% dos casos	Poucos sintomas associados	Lacrimejamento, congestão nasal, ptose e miose ipsilaterais , agitação psicomotora
Tratamento agudo	AINE ou triptano	Analgésico simples	Oxigênio a 100% e/ou sumatriptano subcutâneo
Profilaxia	Betabloqueador, amitriptilina, topiramato, flunarizina, anticorpos anti-CGRP nos casos refratários	Amitriptilina	Verapamil

Sinais de alarme que exigem investigação com neuroimagem: início súbito e explosivo ("a pior dor de cabeça da vida" — pensar em **hemorragia subaracnóidea**), início após os 50 anos, piora progressiva ao longo de semanas, presença de sinal neurológico focal, papiledema, febre associada a rigidez de nuca, contexto de imunossupressão ou câncer, despertar noturno pela dor, piora com manobra de Valsalva (tosse, esforço evacuatório).

Lembrete de interface com GO: enxaqueca **com aura** contraindica em absoluto o uso de contraceptivo combinado.

PARTE VI — NEUROLOGIA

6.2 Doença cerebrovascular

Déficit neurológico focal de início súbito → **TC de crânio sem contraste imediata**, para diferenciar isquêmico de hemorrágico antes de qualquer outra conduta.

AVC isquêmico: trombólise endovenosa (alteplase ou tenecteplase) em até 4,5 horas do início inequívoco dos sintomas; **trombectomia mecânica** para oclusão de grande vaso, com janela que pode se estender em casos selecionados guiados por imagem de perfusão.

Contraindicações à trombólise: hemorragia intracraniana atual ou prévia, TCE ou AVC recente, cirurgia de grande porte recente, sangramento ativo, **PA > 185/110 mmHg não controlada**, plaquetopenia significativa, uso de anticoagulante com INR/tempo de coagulação alterado.

Não reduzir a PA agressivamente no AVC isquêmico não trombolisado — tolera-se PA elevada (até cerca de 220/120) na fase aguda, salvo indicação específica de tratamento.

Prevenção secundária: antiagregação plaquetária, estatina de alta potência, controle rigoroso dos fatores de risco vascular; **anticoagulação se fibrilação atrial** for a causa identificada.

Ataque isquêmico transitório: déficit transitório sem infarto estabelecido em imagem — deve ser investigado e tratado com a mesma urgência de uma emergência vascular (escore ABCD² para estratificar risco de AVC subsequente).

Hemorragia subaracnóidea: cefaleia súbita e intensa, podendo haver rigidez de nuca; TC de crânio é o primeiro exame — se negativa e a suspeita clínica persistir, **punção lombar** em busca de xantocromia; angiografia para identificar aneurisma.

Hemorragia intraparenquimatosa: mais associada a hipertensão crônica mal controlada (núcleos da base, tálamo, cerebelo, ponte) ou a angiopatia amiloide no idoso (lobar); controle pressórico e avaliação neurocirúrgica conforme volume e localização.

PARTE VI — NEUROLOGIA

6.3 Epilepsia

Diagnóstico de epilepsia exige **crise não provocada** recorrente (ou uma crise com alta probabilidade de recorrência); investigar com **EEG** e neuroimagem.

Crise de ausência da infância: episódios breves de desligamento, múltiplos ao dia, provocáveis por hiperventilação; EEG com espícula-onda a 3 Hz.

Epilepsia mioclônica juvenil: mioclonias matinais, crises tônico-clônicas generalizadas, frequentemente desencadeadas por privação de sono.

Escolha do anticonvulsivante conforme o tipo de crise (focal x generalizada) e o perfil do paciente (evitar valproato em mulheres em idade fértil, pelo risco teratogênico).

Estado de mal epiléptico: crise contínua ou crises repetidas sem recuperação da consciência por mais de 5 minutos → **benzodiazepínico** como primeira linha, seguido de anticonvulsivante endovenoso (fenitoína, valproato ou levetiracetam) se não houver resposta.

PARTE VI — NEUROLOGIA

6.4 Demências e distúrbios do movimento

Doença de Alzheimer: início insidioso, **comprometimento da memória episódica recente** como primeiro domínio afetado, anosognosia (o paciente minimiza o problema); tratamento sintomático com inibidores da colinesterase e memantina.

Demência vascular: evolução em degraus, coexistência de fatores de risco vascular, sinais neurológicos focais ao exame.

Demência com corpos de Lewy: **flutuação cognitiva, alucinações visuais bem formadas e parkinsonismo** desde o início; **hipersensibilidade grave a antipsicóticos típicos** — evitar neurolépticos nesses pacientes.

Demência frontotemporal: alterações de comportamento, personalidade e linguagem precedendo o comprometimento de memória, em pacientes tipicamente mais jovens (< 65 anos).

Diferenciais obrigatórios da síndrome demencial: **delirium** (início agudo, curso flutuante ao longo do dia, com déficit de atenção — sempre buscar causa orgânica reversível), depressão ("pseudodemência" — melhora com tratamento do humor), hipotireoidismo, deficiência de vitamina B12, neurosífilis, e **hidrocefalia de pressão normal** (triade **apraxia de marcha + incontinência urinária + declínio cognitivo** — potencialmente reversível com derivação líquórica).

Doença de Parkinson: **bradicinesia obrigatória**, associada a pelo menos um de: tremor de repouso, rigidez em roda dentada, instabilidade postural (esta, tipicamente tardia); assimetria de início e **boa resposta à levodopa** sustentam o diagnóstico clínico.

Parkinsonismo secundário/medicamentoso: metoclopramida, flunarizina e antipsicóticos são causas frequentes — simétrico, reversível com a suspensão do agente causador; é o principal diferencial a excluir antes de rotular como doença de Parkinson idiopática.

Tremor essencial: tremor de ação/postural (não de repouso), frequentemente familiar, melhora classicamente com álcool — diferencia-se do Parkinson pela ausência de bradicinesia e rigidez.

PARTE VI — NEUROLOGIA

6.5 Doenças desmielinizantes e neuromusculares

Esclerose múltipla: adulto jovem, episódios neurológicos **disseminados no tempo e no espaço** (nevrite óptica, mielite transversa parcial, sintomas de tronco/cerebelo), com RM mostrando lesões desmielinizantes características (periventriculares, justacorticais); tratamento com imunomoduladores conforme atividade da doença.

Síndrome de Guillain-Barré: paralisia flácida **ascendente e simétrica**, arreflexia, frequentemente após infecção respiratória ou gastrointestinal (associação clássica com *Campylobacter jejuni* e, no Brasil, com Zika); líquido com **dissociação proteíno-citológica** (proteína elevada, celularidade normal); tratamento com **imunoglobulina EV ou plasmaférese**; monitorar função respiratória de perto (risco de insuficiência respiratória).

Myastenia gravis: fraqueza muscular **flutuante, que piora com o esforço repetido e melhora com o repouso**, ptose e diplopia frequentes, podendo progredir para fraqueza bulbar e respiratória (crise miastênica); anticorpo anti-receptor de acetilcolina; tratamento com anticolinesterásico, imunossupressão e, na crise, imunoglobulina/plasmaférese.

Neuropatia periférica diabética: a causa mais comum de neuropatia periférica no adulto; padrão em bota e luva, sensitivo-motora.

PARTE VI — NEUROLOGIA

6.6 Vertigem e outras síndromes neurológicas

Ver detalhamento da vertigem periférica (VPPB, neurite vestibular, Ménière) no bloco de Otorrinolaringologia (item 47) — o essencial em neurologia é **diferenciar vertigem central de periférica**: nistagmo que muda de direção, não se suprime com fixação visual, associado a outros sinais de tronco encefálico (diplopia, disartria, ataxia de membros) sugere causa **central** e exige neuroimagem urgente.

Compressão medular aguda: dor localizada, fraqueza progressiva, nível sensitivo, disfunção esfinteriana → **emergência**, RM de urgência; causas incluem metástase vertebral, abscesso epidural e hérnia discal extrusa. **Síndrome da cauda equina** (retenção urinária, anestesia em sela, fraqueza de membros inferiores) é emergência cirúrgica.

PARTE VII — REUMATOLOGIA

7.1 Artrite reumatoide e osteoartrite

Artrite reumatoide: poliartrite **simétrica de pequenas articulações** (mãos, punhos, pés), **rigidez matinal com duração superior a 1 hora**, fator reumatoide e **anti-CCP** (mais específico) positivos; erosões articulares em radiografia nas fases mais avançadas. **Metotrexato precoce** é a base do tratamento, com biológicos reservados a casos refratários.

Osteoartrite: dor articular de padrão **mecânico** (piora com uso, melhora com repouso), rigidez matinal breve (< 30 minutos), crepitação à mobilização, **nódulos de Heberden (interfalangeanas distais) e Bouchard (proximais)**; tratamento com analgesia, fisioterapia e, em casos avançados, artroplastia.

PARTE VII — REUMATOLOGIA

7.2 Lúpus eritematoso sistêmico e síndrome antifosfolípide

LES: predomínio em mulheres jovens, doença multissistêmica (cutânea, articular, renal, hematológica, neurológica, serosite); **FAN** como teste de triagem de alta sensibilidade; **anti-DNA dupla hélice e anti-Sm** são específicos; **consumo de complemento (C3/C4 baixos)** reflete atividade da doença. A **nefrite lúpica** é o principal determinante de morbimortalidade — biópsia renal orienta classe histológica e tratamento.

Síndrome antifosfolípide: trombozes arteriais/venosas de repetição e/ou perdas gestacionais recorrentes, associadas a anticorpos antifosfolípidos (anticoagulante lúpico, anticardiolipina, anti-beta2-glicoproteína) — pode ser primária ou associada ao LES; anticoagulação plena é o tratamento nas formas trombóticas.

PARTE VII — REUMATOLOGIA

7.3 Espondiloartropatias

Espondilite anquilosante: homem jovem, **lombalgia inflamatória** (piora com repouso e ao amanhecer, melhora com exercício, rigidez matinal prolongada), **sacroiliíte** em imagem, associação com **HLA-B27**, uveíte anterior aguda recorrente.

Artrite psoriásica: psoríase cutânea associada a artrite (padrão variável, incluindo dactilite "em salsicha" e acometimento de interfalangeanas distais), alterações ungueais características.

Artrite reativa: tríade clássica de artrite + uretrite + conjuntivite após infecção genital ou entérica.

Doença inflamatória intestinal com artrite associada: espondiloartrite pode acompanhar Crohn e retocolite.

PARTE VII — REUMATOLOGIA

7.4 Artropatias por cristais

Gota: monoartrite aguda de início súbito, clássica em **1ª articulação metatarsfalângica (podagra)**, mais comum em homens com uso de álcool e dieta rica em purinas; **cristais de urato monossódico, birrefringência negativa** na análise do líquido sinovial. Tratamento da crise: **AINE, colchicina ou corticoide** — **nunca iniciar ou suspender alopurinol durante a crise aguda** (pode prolongar ou desencadear nova crise); hipouricemiante iniciado/mantido apenas após resolução, com cobertura de colchicina profilática ao introduzir.

Doença por depósito de pirofosfato de cálcio (pseudogota): idoso, joelho é a articulação mais acometida, **cristais de pirofosfato, birrefringência positiva fraca**; condrocalcinose em radiografia.

PARTE VII — REUMATOLOGIA

7.5 Vasculites e outras doenças autoimunes sistêmicas

Arterite de células gigantes (temporal): idade > 50 anos, cefaleia temporal, claudicação de mandíbula à mastigação, **risco de amaurose súbita e irreversível** → **corticoide em altas doses deve ser iniciado imediatamente, sem aguardar a biópsia** de artéria temporal (que segue sendo feita para confirmação, mas não retarda o tratamento).

Polimialgia reumática: associada à arterite de células gigantes; dor e rigidez em cinturas escapular e pélvica em > 50 anos, **VHS muito elevado**, resposta dramática a baixa dose de corticoide.

Poliarterite nodosa: vasculite de médios vasos, pode acometer múltiplos órgãos (pele, rins, nervos periféricos, trato gastrointestinal), associação com hepatite B.

Granulomatose com poliangiite (antiga Wegener): trato respiratório superior e inferior + glomerulonefrite, **ANCA-c/anti-PR3** positivo.

Poliangiite microscópica e granulomatose eosinofílica com poliangiite (Churg-Strauss): associadas a **ANCA-p/anti-MPO**; esta última com asma e eosinofilia proeminentes.

Esclerose sistêmica (esclerodermia): espessamento cutâneo, **fenômeno de Raynaud**, disfagia por dismotilidade esofágica, fibrose pulmonar, crise renal esclerodérmica.

Síndrome de Sjögren: xerostomia e xeroftalmia (síndrome sicca), anti-Ro/SSA e anti-La/SSB, risco aumentado de linfoma.

Miopatias inflamatórias (dermatomiosite e polimiosite): fraqueza muscular proximal simétrica, enzimas musculares elevadas (CPK); a dermatomiosite acrescenta achados cutâneos característicos (heliótopo, pápulas de Gottron) e maior associação com neoplasia oculta em adultos.

PARTE VII — REUMATOLOGIA

7.6 Fibromialgia e lombalgia

Fibromialgia: dor musculoesquelética difusa e crônica, **sono não reparador**, fadiga, sem sinais inflamatórios ao exame ou laboratório — diagnóstico clínico; tratamento centrado em exercício físico regular, higiene do sono e, quando necessário, antidepressivos/anticonvulsivantes com ação em dor crônica.

Lombalgia: a maioria dos casos é inespecífica e melhora em poucas semanas com **manutenção da atividade física e analgesia — sem indicação de imagem de rotina**. Solicitar imagem apenas com **sinais de alarme:** início após os 50 anos, trauma significativo, febre, perda de peso inexplicada, história de câncer, imunossupressão, uso de drogas injetáveis, déficit neurológico progressivo, ou suspeita de **síndrome da cauda equina** (emergência cirúrgica).

PARTE VIII — NEFROLOGIA

8.1 Doença renal crônica

KDIGO 2024 mantém a classificação por TFG e albuminúria, reforçando o acrônimo **CGA** (Causa, categoria de **TFG (G)** e categoria de **Albuminúria (A)**) para descrever cada paciente de forma completa, e recomenda o uso de **calculadoras de risco de progressão** (como a *Kidney Failure Risk Equation*) nos estágios G3 a G5.

ESTÁGIO	TFG (ML/MIN/1,73M ²)
G1	≥ 90 (com marcador de lesão renal)
G2	60–89 (com marcador de lesão renal)
G3a	45–59
G3b	30–44
G4	15–29
G5	< 15 (falência renal)

Definição: anormalidade de estrutura ou função renal, presente por **≥ 3 meses**, com implicação para a saúde.

Investigar etiologias além do diabetes quando houver: hematúria dismórfica, cilindros hemáticos, ausência de retinopatia diabética em paciente diabético com proteinúria significativa (sugere causa não diabética).

Tratamento: controle rigoroso de PA e glicemia, **IECA/BRA e inibidor de SGLT2** (ver Endocrinologia — indicação expandida para TFGe < 60 mesmo sem albuminúria/HAS), manejo da anemia (eritropoetina, ferro), do distúrbio mineral ósseo (fósforo, PTH, vitamina D) e da acidose metabólica.

Indicações de diálise (crônica): uremia sintomática, sobrecarga volêmica refratária, distúrbio eletrolítico grave refratário, geralmente com TFG muito baixa (< 10–15), individualizado pelo quadro clínico.

PARTE VIII — NEFROLOGIA

8.2 Injúria renal aguda

Classificar por critérios de creatinina e débito urinário (KDIGO).

Pré-renal (a causa mais comum): **FeNa < 1%**, relação ureia/creatinina elevada, urina concentrada — responde à reposição volêmica.

Necrose tubular aguda (intrínseca): **FeNa > 2%**, cilindros granulosos "sujeitos" na urina, geralmente por isquemia prolongada ou nefrotoxicidade (contraste, aminoglicosídeo, rabdomiólise).

Pós-renal: obstrução do trato urinário → **ultrassonografia com hidronefrose** confirma; desobstrução é a conduta.

Indicações de diálise de urgência (mnemônico AEIOU): **A**cidose metabólica refratária, **E**letrólitos (hipercalcemia grave refratária), **I**ntoxicações por substâncias dialisáveis, **S**obrecarga volêmica refratária a diurético, **U**remia sintomática (encefalopatia, pericardite urêmica).

PARTE VIII — NEFROLOGIA

8.3 Distúrbios ácido-base

Abordagem sistemática: pH define acidose/alcalose; PaCO_2 e bicarbonato definem se o distúrbio primário é respiratório ou metabólico; calcular a **compensação esperada** para identificar distúrbio misto.

Ânion gap = $\text{Na} - (\text{Cl} + \text{HCO}_3)$; elevado sugere acidose por ácidos não mensurados (cetoacidose, acidose láctica, intoxicações, uremia); normal (hiperclorêmica) sugere perda de bicarbonato (diarreia, acidose tubular renal).

Acidose respiratória: hipoventilação (DPOC exacerbado, opioides, doença neuromuscular).

Alcalose respiratória: hiperventilação (ansiedade, dor, hipóxia, sepse inicial, gestação).

Acidose metabólica: causas com ânion gap alto (cetoacidose, acidose láctica, uremia, intoxicações — metanol, etilenoglicol, salicilato) e com ânion gap normal (diarreia, acidose tubular renal, uso de acetazolamida).

Alcalose metabólica: vômitos, uso de diurético, hiperaldosteronismo — geralmente com hipocalemia associada.

PARTE VIII — NEFROLOGIA

8.4 Distúrbios eletrolíticos

Hipercalcemia: alterações eletrocardiográficas progressivas (onda T apiculada → alargamento de QRS → padrão sinusoidal) → **gluconato de cálcio** (estabiliza a membrana miocárdica, não baixa o potássio), seguido de **insulina com glicose**, beta-agonista inalatório, resina de troca, e **diálise** nos casos refratários ou muito graves.

Hiponatremia: avaliar volemia para classificar a causa; corrigir **lentamente** (risco de **mielinólise pontina** se corrigida rápido demais); se sintomática grave (convulsão, rebaixamento) → salina hipertônica 3% em bólus controlado.

Hipernatremia: geralmente por perda de água livre; corrigir em **48 horas** (risco de edema cerebral se corrigida rápido demais).

Hipocalcemia/hipercalcemia: ver blocos de Endocrinologia (paratireoide) — sinais de Chvostek/Trousseau na hipocalcemia; letargia, constipação, poliúria e "ossos, pedras, gemidos e lamentos abdominais" na hipercalcemia.

Hipomagnesemia: frequentemente acompanha hipocalcemia e hipocalcemia refratárias — corrigir o magnésio para conseguir corrigir os demais.

PARTE VIII — NEFROLOGIA

8.5 Síndromes glomerulares e ITU no adulto

Síndrome nefrítica: hematúria (frequentemente dismórfica), hipertensão, edema, graus variáveis de disfunção renal — pensar em glomerulonefrite pós-infecciosa, nefropatia por IgA, entre outras (ver detalhamento pediátrico da GNPE no Rapid Review de Pediatria, aplicável também ao adulto).

Síndrome nefrótica: proteinúria maciça ($> 3,5$ g/24h), hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia — no adulto, glomerulopatia membranosa e doença de lesões mínimas (esta mais em crianças) e nefropatia diabética são causas frequentes; risco de trombose venosa (incluindo veia renal) e infecção.

ITU no adulto: cistite (disúria, polaciúria, urgência) → nitrofurantoína ou fosfomicina; **pielonefrite** (febre, dor lombar, sinal de Giordano positivo) → antibiótico por 7–14 dias, internação se toxemia, vômitos incoercíveis ou gestação. **Bacteriúria assintomática só se trata em gestantes e antes de procedimento urológico invasivo** — tratar fora dessas situações é conduta incorreta.

PARTE IX — HEMATOLOGIA

9.1 Anemias — mecanismo orienta o raciocínio

TIPO	MECANISMO	ACHADOS-CHAVE
Ferropriva	Perda sanguínea (investigar sempre trato digestivo no adulto) ou baixa ingesta/absorção	Microcítica, hipocrômica, ferritina baixa , RDW alto
Doença crônica	Sequestro de ferro mediado por inflamação	Microcítica/normocítica, ferritina normal ou alta , saturação de transferrina baixa
Megaloblástica	Deficiência de B12 ou folato	Macroscítica, neutrófilos hipersegmentados , pode cursar com sintomas neurológicos (só na deficiência de B12)
Hemolítica	Destrução aumentada de hemácias	Reticulocitose, LDH elevado , haptoglobina baixa , icterícia indireta; Coombs direto positivo nas autoimunes
Aplásica/infiltrativa	Falência medular	Pancitopenia → mielograma/biópsia de medula

Anemia ferropriva no homem adulto ou na mulher pós-menopausa exige investigação de sangramento digestivo — não tratar apenas com reposição de ferro sem buscar a causa.

Anemia falciforme: crises vaso-oclusivas dolorosas, **síndrome torácica aguda** (a principal causa de morte no adulto com a doença), sequestro esplênico, priapismo, úlceras maleolares, risco aumentado de AVC; hidroxíureia reduz frequência de crises.

PARTE IX — HEMATOLOGIA

9.2 Neoplasias hematológicas

Leucemias agudas (LMA e LLA): instalação rápida, pancitopenia com **blastos circulantes**, sintomas de falência medular (anemia, sangramento, infecção) → mielograma confirma.

Leucemias crônicas (LMC e LLC): curso mais insidioso; LMC associada ao cromossomo Filadélfia (BCR-ABL), tratada com inibidor de tirosina-quinase; LLC mais comum em idosos, frequentemente achado incidental de linfocitose.

Linfomas: adenomegalia **indolor, endurecida, persistente**, podendo vir com **sintomas B** (febre, sudorese noturna, perda de peso); **Hodgkin** (células de Reed-Sternberg, disseminação contígua e mais previsível) × **não Hodgkin** (mais heterogêneo, disseminação menos previsível) — biópsia excisional do linfonodo confirma.

Mieloma múltiplo: idoso, dor óssea, achados de **CRAB** (hipercalcemia, insuficiência renal, anemia, lesões ósseas líticas), **pico monoclonal** na eletroforese de proteínas.

PARTE IX — HEMATOLOGIA

9.3 Coagulação, trombofilias e transfusão

Distúrbios de coagulação: hemofilia (TTPa alargado com TP normal, sangramentos articulares e musculares — herança ligada ao X) × **doença de von Willebrand** (sangramento mucocutâneo, a coagulopatia hereditária mais comum).

CIVD: consumo de fatores e plaquetas em contexto de sepse grave, trauma extenso ou complicação obstétrica — sangramento e trombose simultâneos, com plaquetopenia, TP/TTPa alargados, fibrinogênio baixo e D-dímero muito elevado.

Trombofilias hereditárias (fator V de Leiden, mutação da protrombina, deficiências de proteína C/S e antitrombina): investigar em trombose venosa não provocada, recorrente, ou em local incomum, especialmente em jovens.

Anticoagulação: varfarina exige monitorização por INR e sofre múltiplas interações medicamentosas e alimentares; **DOACs** dispensam monitorização de rotina; reversão de varfarina com vitamina K e/ou complexo protrombínico; DOACs têm antídotos específicos conforme a classe.

Reações transfusionais: febril não hemolítica (a mais comum, benigna) × hemolítica aguda (erro de tipagem, gravíssima) × **TRALI** (lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, dispneia e infiltrado pulmonar nas primeiras horas) × sobrecarga circulatória (TACO).

PARTE IX — DERMATOLOGIA

9.1 Infecções de pele

Erisipela x celulite x fasciite necrotizante: ver detalhamento na Parte I (item 8).

Impetigo: crostas melicéricas (não bolhoso) ou bolhas flácidas (bolhoso, por *S. aureus*) — mais comum em crianças, mas ocorre em adultos; tratamento tópico se localizado, sistêmico se extenso.

Micoses superficiais: tinha do corpo, do pé (intertrigo interdigital), **onicomicose**; **tinha do couro cabeludo sempre exige tratamento antifúngico sistêmico** (o tópico isolado não penetra o folículo).

Pitíriase versicolor: máculas hipo ou hiperocrômicas, descamação fina ao estiramento (sinal de Zileri), mais comum em áreas seborreicas.

Escabiose: prurido de predomínio **noturno**, túneis interdigitais, acometimento de contactantes domiciliares → permetrina tópica ou ivermectina oral, tratando contatos e roupas de cama simultaneamente.

Herpes zóster: erupção vesicular dolorosa em **distribuição dermatomal unilateral**, reativação do vírus varicela-zóster latente; antiviral precoce reduz risco de neuralgia pós-herpética, especialmente no idoso.

PARTE IX — DERMATOLOGIA

9.2 Dermatoses inflamatórias e farmacodermias

Psoríase: placas eritematodescamativas bem delimitadas em superfícies extensoras (cotovelos, joelhos) e couro cabeludo, **sinal de Auspitz** (sangramento puntiforme ao remover a escama); pode associar-se a artrite psoriásica (ver Reumatologia).

Dermatite atópica e seborreica: ver detalhamento pediátrico no Rapid Review de Pediatria — no adulto seguem os mesmos princípios de hidratação e corticoide tópico nas crises.

Urticária e angioedema: pápulas/placas pruriginosas fugazes < 24h cada lesão; investigar causa se recorrente; angioedema sem urticária associado a IECA sugere mecanismo bradikinérgico, não alérgico clássico — suspender o IECA.

Farmacodermias: exantema morbiliforme é a apresentação mais comum e geralmente benigna; **atenção às formas graves — síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica** (acometimento de mucosas, **sinal de Nikolsky positivo**, descolamento cutâneo extenso — emergência, suspender o fármaco agressor imediatamente) e **DRESS** (eosinofilia, febre, adenopatia, hepatite, início tardio após exposição ao fármaco).

Doenças bolhosas autoimunes: **pênfigo vulgar** (bolhas flácidas, **Nikolsky positivo**, acometimento de mucosas, acantólise suprabasal) × **penfigoide bolhoso** (bolhas tensas, predomínio em idosos, **Nikolsky negativo**, sem acometimento importante de mucosas) — distinção clássica de prova.

PARTE IX — DERMATOLOGIA

9.3 Câncer de pele

Carcinoma basocelular: o mais comum, **pápula perolada com telangiectasias**, crescimento lento, metástase excepcional.

Carcinoma espinocelular: geralmente sobre lesão precursora (ceratose actínica, cicatriz crônica), ulcerado ou verrucoso, **maior risco de metástase** que o basocelular.

Melanoma: regra **ABCDE** (Assimetria, Bordas irregulares, Cor heterogênea, Diâmetro > 6 mm, Evolução) — a **espessura de Breslow** define prognóstico e conduta cirúrgica.

PARTE X — EMERGÊNCIAS CLÍNICAS

9.1 Ressuscitação cardiopulmonar

A AHA publicou em outubro de 2025 a primeira revisão completa das diretrizes de RCP desde 2020, cobrindo adulto, pediatria e neonatologia, com ensino obrigatório a partir de março de 2026.

O que mudou e vale ponto:

Cadeia de sobrevivência unificada em 6 elos, no lugar das cadeias separadas por cenário.

Nos ritmos chocáveis, a adrenalina passou a ser postergada até depois da primeira desfibrilação; quando indicada, a **adrenalina isolada é preferida à combinação com vasopressina**.

RCP mecânica não é recomendada de rotina; RCP com cabeça elevada não é recomendada fora de estudo clínico.

Engasgo em adulto e criança consciente: sequência padronizada de **5 golpes no dorso seguidos de 5 compressões abdominais**, alternando os dois métodos.

Acesso público à naloxona passa a ser recomendado ao lado do acesso público ao desfibrilador, reconhecendo a relevância das overdoses por opioide.

Monitorização fisiológica em tempo real (capnografia) para avaliar a qualidade da RCP — **PETCO₂ < 10 mmHg sugere compressões inadequadas** (trocar o compressor, aumentar a profundidade, ou revisar a ventilação).

O que permanece: compressões a **100–120/min**, profundidade de **5–6 cm no adulto**, retorno completo do tórax entre compressões, **fração de compressão ≥ 80%** (pausas < 10 segundos para checagem de ritmo, desfibrilação ou manejo de via aérea), relação **30:2 antes da via aérea avançada**, ventilação assíncrona (1 a cada 6 segundos) depois de via aérea avançada estabelecida.

Ritmos e conduta:

Chocáveis (FV/TV sem pulso): desfibrilar imediatamente, retomar compressões, considerar amiodarona ou lidocaina se refratário.

Não chocáveis (assistolia/AESP): RCP de alta qualidade + adrenalina o quanto antes + busca ativa das **causas reversíveis (5H e 5T)**: hipóxia, hipovolemia, hidrogênio (acidose), hipo/hipercalcemia, hipotermia; tensão no tórax (pneumotórax), tamponamento, toxinas, trombose pulmonar, trombose coronariana.

PARTE X — EMERGÊNCIAS CLÍNICAS

9.2 Choque

Classificação: hipovolêmico (hemorragia, perdas de volume), cardiogênico (falência de bomba), distributivo (séptico, anafilático, neurogênico) e obstrutivo (tamponamento, pneumotórax hipertensivo, TEP maciço).

Reconhecimento precoce: taquicardia, tempo de enchimento capilar prolongado, extremidades frias (exceto no distributivo, onde podem estar quentes na fase inicial), alteração do sensório, oligúria — **hipotensão é sinal tardio**, sobretudo em pacientes jovens compensados.

Choque séptico: ver Parte I, item 7 — pacote da primeira hora, noradrenalina como vasopressor de escolha.

Choque anafilático: ver item 60 abaixo.

Choque neurogênico: hipotensão **com bradicardia** (perda do tônus simpático) após lesão medular alta — volume e vasopressor; sempre excluir hemorragia associada antes de atribuir a hipotensão apenas ao componente neurogênico.

PARTE X — EMERGÊNCIAS CLÍNICAS

9.3 Intoxicações exógenas

Princípios gerais: suporte de via aérea, respiração e circulação sempre em primeiro lugar; **descontaminação gástrica com carvão ativado** apenas em janela precoce (1–2 horas) e via aérea protegida; **lavagem gástrica é exceção**, reservada a poucas situações; **xarope de ipeca está proscrito**.

Antídotos que a prova cobra por associação direta:

INTOXICAÇÃO	ANTÍDOTO
Paracetamol	N-acetilcisteína
Opioides	Naloxona
Benzodiazepínicos	Flumazenil (usar com cautela — risco de convulsão em dependentes crônicos)
Organofosforados (síndrome colinérgica)	Atropina + pralidoxima
Metemoglobinemia	Azul de metileno
Metanol/etilenoglicol	Etanol ou fomepizol
Ferro	Deferoxamina
Chumbo	Quelantes (EDTA, dimercaprol)
Digoxina	Anticorpo antidigoxina (Fab)

PARTE X — EMERGÊNCIAS CLÍNICAS

9.4 Anafilaxia

Adrenalina intramuscular 0,01 mg/kg (máximo 0,5 mg) na face anterolateral da coxa é a primeira e mais importante medida, repetível a cada 5–15 minutos se necessário — **nunca atrasar a adrenalina para administrar anti-histamínico ou corticoide primeiro** (estes são apenas adjuvantes).

Observação por **4 a 6 horas** pelo risco de **reação bifásica** (recorrência dos sintomas sem nova exposição ao alérgeno).

PARTE X — EMERGÊNCIAS CLÍNICAS

9.5 Acidentes por animais peçonhentos

ACIDENTE	QUADRO	CONDUTA
Botrópico	Dor, edema local, sangramento e incoagulabilidade sanguínea	Soro antibotrópico conforme gravidade
Crotálico	Fácies miastênica (ptose, diplopia), mialgia generalizada, rabdomiólise com urina escura	Soro anticrotálico; monitorar função renal
Laquético	Semelhante ao botrópico, com manifestações vagas (bradicardia, diarreia)	Soro específico
Elapídico (coral)	Neurotóxico, paralisia flácida progressiva, risco de insuficiência respiratória	Soro antielapídico
Escorpiônico	Dor imediata intensa; gravidade maior em crianças , com risco de disfunção cardiorrespiratória	Soro antiescorpiônico nos casos moderados/graves

Todos são de **notificação compulsória**.

PARTE X — EMERGÊNCIAS CLÍNICAS

9.6 Afogamento, hipotermia e distúrbios térmicos

Afogamento: a principal lesão é a **hipóxia** — priorizar ventilação precoce, mesmo antes das compressões, se o resgatista estiver treinado; a manobra de Heimlich não é recomendada como rotina no afogamento (a água nos pulmões é absorvida, não "obstrui" como corpo estranho).

Hipotermia acidental: reaquecimento gradual; em PCR por hipotermia grave, considerar prolongar as manobras de reanimação até normalização térmica ("não está morto até estar quente e morto").

Golpe de calor: hipertermia grave ($> 40^{\circ}\text{C}$) com disfunção neurológica, em geralmente idosos ou atletas em ambiente quente → resfriamento ativo imediato, é emergência com risco de vida.

PARTE XI — GERIATRIA

9.1 Síndromes geriátricas e prescrição no idoso

"Gigantes da geriatria": instabilidade postural e **quedas**, imobilidade, incontinência urinária, **incapacidade cognitiva**, iatrogenia (efeitos adversos de medicações).

Polifarmácia: revisar periodicamente com os **critérios de Beers/STOPP-START**; evitar no idoso, sempre que possível: benzodiazepínicos, anticolinérgicos, antipsicóticos para sintomas comportamentais de demência (aumentam mortalidade), AINEs crônicos.

Delirium: início **agudo**, curso **flutuante**, **déficit de atenção** como achado central — sempre buscar a causa (infecção, dor não controlada, retenção urinária/fecal, efeito medicamentoso, distúrbio metabólico, privação sensorial); manejo **não farmacológico é a primeira linha** (orientação, ambiente calmo, presença de familiares, correção da causa).

Avaliação geriátrica ampla: funcionalidade (**AVD de Katz** para atividades básicas, **AIVD de Lawton** para atividades instrumentais), cognição, humor, mobilidade e risco de queda, estado nutricional, suporte social.

Fragilidade: fenótipo com perda de peso não intencional, exaustão autorreferida, fraqueza (força de preensão reduzida), lentidão da marcha e baixo nível de atividade física — três ou mais critérios definem fragilidade.

PARTE XII — OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA

9.1 Olho vermelho e emergências oftalmológicas

QUADRO	CHAVE	CONDUTA
Conjuntivite	Secreção, sem dor importante, visão preservada	Sintomático; antibiótico tópico se bacteriana
Uveíte	Dor, fotofobia, miose , hiperemia perilábica	Encaminhamento oftalmológico, corticoide conforme causa
Glaucoma agudo de ângulo fechado	Dor ocular intensa, náusea/vômito, midríase média fixa , halos coloridos, visão turva súbita	Emergência — reduzir a PIO imediatamente (acetazolamida, agentes tópicos) e encaminhar
Cerátite	Uso de lente de contato, dor, fotofobia, sensação de corpo estranho	Suspender lente, antibiótico tópico, avaliação oftalmológica

Perda visual súbita indolor: pensar em **oclusão de artéria ou veia central da retina**, descolamento de retina, neurite óptica (esta pode ter dor à movimentação ocular) — encaminhamento urgente em todos os casos.

Trauma ocular químico: **irrigação copiosa e imediata**, antes de qualquer outra medida — álcalis causam lesão mais profunda e grave que ácidos.

PARTE XII — OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA

9.2 Vertigem e perda auditiva

	VPPB	NEURITE VESTIBULAR	DOENÇA DE MÉNIÈRE
Duração	Episódios breves (segundos), desencadeados por posição	Continua por dias , sem flutuação	Episódica, minutos a horas
Sintoma auditivo	Ausente	Ausente	Hipoacusia flutuante + zumbido + plenitude aural
Diagnóstico	Manobra de Dix-Hallpike positiva	Clínico, quadro viral prévio	Clínico, tríade característica
Tratamento	Manobra de Epley	Sintomático, corticoide precoce pode ajudar	Restrição de sal, diurético

Sinais de alerta para vertigem central (exigem neuroimagem): nistagmo que muda de direção ou é vertical, não suprimido pela fixação visual, associado a diplopia, disartria ou ataxia de membros.

Perda auditiva: condutiva (cerume, otite média, otosclerose) × **neurossensorial** (presbiacusia, exposição a ruído, ototóxicos) — **testes de Weber e Rinne** ao diapasão ajudam a diferenciar à beira do leito.

PARTE XII — OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA

9.3 Epistaxe

A maioria é anterior (plexo de Kiesselbach) → **compressão digital do terço anterior do nariz por 10–15 minutos** contínuos, com a cabeça inclinada para frente; cauterização química ou elétrica se recorrente; tamponamento anterior se refratário; epistaxe posterior (mais rara, mais grave, mais comum no idoso hipertenso) pode exigir tamponamento posterior ou abordagem especializada.

CHECKLIST FINAL

✓ 100 frases para a véspera

INFECTOLOGIA

- 1 **TARV para todos** com HIV, esquema preferencial **TDF/3TC/DTG**.
- 2 **CD4 < 200** → **profilaxia com sulfametoxazol-trimetoprima** (pneumocistose e toxoplasmose).
- 3 Pneumocistose: hipoxemia desproporcional, LDH alta; **corticoide se PaO₂ < 70**.
- 4 Neurotoxoplasmose: **lesões com realce anelar**; falha de resposta em 2 semanas sugere linfoma de SNC.
- 5 Criptococose: **tinta da China/antígeno criptocócico**; punções de alívio são essenciais.
- 6 **PEP em até 72 horas** (ideal 2h), por **28 dias**.
- 7 **"Indetectável = intransmissível."**
- 8 Uretrite: **ceftriaxona + azitromicina**, tratando gonococo e clamídia empiricamente.
- 9 Úlcera única indolor de base endurecida = sífilis; múltiplas dolorosas com fundo sujo = cancro mole.
- 10 Sífilis recente: **benzatina dose única**; tardia: **3 doses semanais**.
- 11 **Jarisch-Herxheimer não é alergia** — não suspende o tratamento.
- 12 Sintomático respiratório = tosse por **3 semanas**; exame inicial é o **TRM-TB**.
- 13 Esquema básico da TB: **RHZE 2 meses + RH 4 meses**; meningoencefálica e osteoarticular estendem para **10 meses de manutenção**.
- 14 Rifampicina deixa secreções alaranjadas — **efeito esperado, não suspender**.
- 15 Etambutol → **neurite óptica**; pirazinamida → **hiperuricemia**.
- 16 ILTB: PT ≥ 5 mm com RX normal → isoniazida, rifampicina ou **3HP**.
- 17 Hanseníase: **lesão com alteração de sensibilidade** + espessamento neural; diagnóstico é **clínico**.
- 18 **Reação hansênica não é falha terapêutica** — não suspende a PQT.
- 19 Anti-HBs isolado = **vacinado**; anti-HBs + anti-HBc IgG = **curado**; anti-HBc IgM = **agudo**.
- 20 Hepatite C trata com **DAA**, cura em mais de 95%.
- 21 Dengue grupo C: **10 mL/kg/h**; grupo D: **20 mL/kg em 20 min**; **nunca AAS/AINE**.
- 22 Febre maculosa: exantema em **palmas e plantas** → **doxiciclina imediata**, sem esperar sorologia.
- 23 Malária: **gota espessa**, mesmo sem febre no momento da consulta.
- 24 Chagas aguda no Brasil hoje: predomina a **transmissão oral**.
- 25 Seps: **hemocultura antes do antibiótico**, ambos na primeira hora; **controle do foco** é decisivo.
- 26 Meningite: **dexametasona antes ou junto** da primeira dose de antibiótico; TC antes da punção só com indicação específica.
- ~ Endocardite: febre + sopro novo + fenômenos embólicos/imunológicos → **critérios de Duke**.

✓ 100 frases para a véspera — continuação

- 49 Doença cardiovascular ou renal → **SGLT2 ou GLP-1** como segundo fármaco.
- 50 **IECA/BRA indicado em todo TFG < 60**, mesmo sem HAS/albuminúria; **não suspender por queda isolada da TFG**.
- 51 **Finerenona e semaglutida** têm recomendação de nefroproteção no diabético.
- 52 **SUS incorporou insulinas análogas** (PCDT DM2, fevereiro de 2026).
- 53 Cetoacidose: **repor potássio antes da insulina se K < 3,3**; não suspender insulina abruptamente.
- 54 Hipotireoidismo subclínico: tratar se **TSH > 10** ou com sintomas/gestação.
- 55 **Propiltiouracil no 1º trimestre**; metimazol depois.
- 56 Tireoidite subaguda: dor cervical, **VHS alta, captação de iodo baixa** — sem antitireoidiano.
- 57 Feocromocitoma: **alfabloqueio sempre antes do betabloqueio**.
- 58 **Fratura por fragilidade define osteoporose**, independentemente do T-score.

GASTRO E HEPATO

- 59 DRGE: endoscopia só com **sinais de alarme**.
- 60 Erradicar *H. pylori* em úlcera péptica e linfoma MALT; controle após 4 semanas com **teste respiratório ou antígeno fecal** — sorologia não serve.
- 61 **Toda úlcera gástrica se biopsia** e tem controle endoscópico.
- 62 **NAFLD/DHGA agora é MASLD**; NASH agora é MASH; diagnóstico exige esteatose + 1 critério cardiometabólico.
- 63 **GASA ≥ 1,1** = hipertensão portal; **PBE ≥ 250 PMN** → cefotaxima + albumina.
- 64 Encefalopatia hepática: **lactulose** + buscar o fator precipitante.
- 65 Doença celíaca: biópsia **com o paciente ainda ingerindo glúten**.

PNEUMOLOGIA

- 66 **Asma: não existe mais resgate só com SABA** — CI-formoterol é o aliviador preferencial em todas as etapas.
- 67 **Alvo de saturação na crise de asma: 92–95% em ≥ 6 anos**.
- 68 **Se sinais de anafilaxia associados à crise de asma, adrenalina antes do broncodilatador**.
- 69 DPOC: **VEF1/CVF < 0,70 pós-broncodilatador**; **cessar tabagismo** é o que muda a história natural.
- 70 VNI reduz mortalidade na exacerbação de DPOC com acidose respiratória.
- 71 **Critérios de Light** definem exsudato pleural; empiema drena.

NEUROLOGIA

- 72 Cefaleia súbita e explosiva → suspeitar de **hemorragia subaracnóide**.
- 73 Cefaleia em salvas: **O₂ a 100%** e sumatriptano subcutâneo.
- 74 AVC isquêmico: **trombólise até 4,5 horas**; **não baixar a PA agressivamente** se não trombolisado.

✓ **100 frases para a véspera — continuação**

- 93** AHA 2025: nos ritmos chocáveis, desfibrile primeiro e adie a adrenalina.
- 94** Engasgo: 5 golpes no dorso + 5 compressões abdominais, alternando.
- 95** $\text{PETCO}_2 < 10 \text{ mmHg}$ durante a RCP sugere compressões inadequadas.
- 96** Anafilaxia: **adrenalina IM na coxa, sempre primeiro**; observar 4–6h pelo risco de reação bifásica.
- 97** Acidente crotálico: **fácies miastênica + rabdomiólise**; botrópico: **incoagulabilidade**.

GERIATRIA

- 98** Delirium: início **agudo**, curso **flutuante**, déficit de **atenção** — manejo não farmacológico primeiro.
- 99** Evitar antipsicótico para sintomas comportamentais de demência — **aumenta mortalidade**.

OFTALMO/ORL

- 100** Glaucoma agudo de ângulo fechado: **midríase fixa + dor + halos** = emergência.